

Buku Ajar

KEBIDANAN KOMUNITAS

POSYANDU, KIA, DAN PELAYANAN BERBASIS KELUARGA

Dian Rahmawati • Diadjeng Setya Wardani • Rizki Amalia

Editor: Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



BUKU AJAR: KEBIDANAN KOMUNITAS: POSYANDU, KIA, DAN PELAYANAN BERBASIS KELUARGA

Penulis:

Dian Rahmawati, SST., MPH
Dr. Diadjeng Setya Wardani, S. Si.T., M.Kes.
Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes.

Editor:

Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

Buku Ajar: Kebidanan Komunitas: Posyandu, KIA, dan Pelayanan Berbasis Keluarga

Penulis:

Dian Rahmawati, SST., MPH

Dr. Diadjeng Setya Wardani, S. Si.T., M.Kes.

Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes.

Editor: Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7756-82-4

Cetakan Pertama: Agustus, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan anugerah-Nya sehingga buku ajar yang berjudul "Pelayanan Kebidanan Komunitas: Gizi Ibu, Bayi, dan Balita, Kesehatan Reproduksi Remaja, serta Keluarga Berencana di Tingkat Komunitas" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber belajar yang diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran mahasiswa kebidanan maupun tenaga kesehatan dalam memahami konsep, prinsip, dan implementasi pelayanan kebidanan berbasis komunitas secara komprehensif.

Pelayanan kebidanan komunitas memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berorientasi pada individu, keluarga, dan masyarakat. Bidan sebagai tenaga kesehatan di lini terdepan dituntut memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi masalah kesehatan, merencanakan intervensi, melaksanakan pelayanan, serta melakukan evaluasi bersama masyarakat dengan mengedepankan pendekatan pemberdayaan dan kolaborasi lintas sektor.

Buku ajar ini disusun secara sistematis dengan mengangkat tiga pokok bahasan utama yang menjadi prioritas dalam pelayanan kebidanan komunitas, yaitu Gizi Ibu, Bayi, dan Balita di Komunitas: Pencegahan Anemia, Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan Stunting; Kesehatan Reproduksi Remaja di Komunitas: Edukasi, Pencegahan Risiko, dan Rujukan; serta Keluarga Berencana di Tingkat Komunitas: Pelayanan, Jejaring, dan Tindak Lanjut. Ketiga topik tersebut dipilih karena memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendukung pencapaian kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas generasi mendatang, serta pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Materi dalam buku ini disajikan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian terkini, kebijakan nasional di bidang kesehatan, serta praktik pelayanan kebidanan berbasis bukti (*evidence-based practice*). Penyajian materi diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis, melakukan analisis situasi di masyarakat, serta menerapkan asuhan kebidanan komunitas secara profesional sesuai standar kompetensi bidan.

Sebagai buku ajar, penyusunan materi juga diarahkan untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*). Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang

bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi kebidanan, serta tenaga kesehatan lainnya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di komunitas.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan isi buku pada edisi berikutnya. Besar harapan penulis agar buku ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, pelayanan kesehatan, serta menjadi salah satu kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, dan keluarga di Indonesia.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi dalam penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ini dapat menjadi media pembelajaran yang bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu kebidanan dan peningkatan kualitas pelayanan kebidanan komunitas.

Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v

BAB 1 GIZI IBU, BAYI, DAN BALITA DI KOMUNITAS: PENCEGAHAN ANEMIA, KEK, DAN STUNTING..... 1

A. Konsep Dasar Gizi dalam Pelayanan Kebidanan Komunitas	8
B. Identifikasi dan Skrining Risiko Anemia pada Ibu Hamil dan Remaja Putri	14
C. Identifikasi dan Deteksi Dini Kekurangan Energi Kronis (KEK)	15
D. Skrining dan Pemantauan Risiko Stunting pada Bayi dan Balita	17
E. Analisis Data KIA dan Surveilans Gizi untuk Penetapan Prioritas	19
F. Penyusunan Paket Intervensi Gizi Berbasis Keluarga	22
G. Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Anemia, KEK, dan Stunting...	24
H. Aktivitas 1- Knows How	26
I. Aktivitas 2 — Shows	27
J. Soal OSCE Kebidanan	29
K. Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Skrining Anemia dan KEK pada Ibu Hamil di Komunitas.....	32
L. Portofolio.....	34
M. Latihan.....	37
N. Rangkuman Materi	40
O. Glosarium	40
P. Referensi	41

BAB 2 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI KOMUNITAS: EDUKASI, PENCEGAHAN RISIKO, DAN RUJUKAN 44

A. Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja	47
B. Perubahan pada Masa Remaja	48
C. Permasalahan Kesehatan Reproduksi Remaja	49
D. Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Komunitas	52
E. Pencegahan Risiko Kesehatan Reproduksi Remaja di Komunitas	54
F. Sistem Rujukan Kesehatan Reproduksi Remaja di Komunitas.....	56
G. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	59
H. Soal OSCE Kebidanan	60
I. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i>	66
J. Red Flags (Tanda Bahaya)	68
K. Form Checklist “Saya Sudah Bisa”	68
L. Template Soal OSCE Kebidanan	68
M. DOPS di Lahan Praktik.....	74

N. Catatan untuk Penilai	74
O. Portofolio.....	74
P. Ringkasan Materi.....	75
Q. Referensi	75

BAB 3 KELUARGA BERENCANA DI TINGKAT KOMUNITAS: PELAYANAN, JEJARING, DAN TINDAK LANJUT	77
A. Konsep Keluarga Berencana Berbasis Komunitas.....	81
B. Pelayanan KB di Tingkat Primer dan Komunitas.....	84
C. Jejaring dan Kemitraan Pelayanan KB.....	88
D. Konseling KB Berbasis Hak dan Pengambilan Keputusan Bersama.....	91
E. Tindak Lanjut Pengguna KB.....	93
F. Aktivitas 1 — Knows How Mini-Case	96
G. Soal OSCE Kebidanan	97
H. Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS).....	103
I. Portofolio.....	105
J. Rangkuman Materi	109
K. Form Checklist “Saya sudah bisa...”	112
L. Referensi	113
PROFIL PENULIS.....	115

BAB 1

GIZI IBU, BAYI, DAN BALITA DI KOMUNITAS: PENCEGAHAN ANEMIA, KEK, DAN STUNTING

Capaian Pembelajaran Lulusan

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, kebijakan, dan prinsip pelayanan kebidanan komunitas serta pelayanan KIA primer berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian kebutuhan dan masalah KIA pada keluarga/komunitas menggunakan data, surveilans, dan analisis prioritas.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-7
CPL-3	Mampu merencanakan dan memberikan asuhan kebidanan berbasis keluarga sepanjang siklus kehidupan dengan kesinambungan layanan (continuity of care).	CPMK-2; CPMK-6
CPL-4	Mampu mengorganisasi dan mengelola layanan KIA berbasis komunitas (Posyandu/UKBM, layanan terpadu) serta membangun jejaring rujukan dan kemitraan.	CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Mampu melakukan komunikasi efektif, KIE, promosi kesehatan, pemberdayaan kader/masyarakat, dan pendekatan sensitif budaya.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-2
CPL-6	Menunjukkan profesionalisme, etika, keselamatan, serta kemampuan monitoring-evaluasi dan perbaikan mutu program KIA.	CPMK-1; CPMK-7; CPMK-3

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menguasai konsep, kebijakan dasar, dan peran profesi dalam kebidanan komunitas serta prinsip etika–keselamatan di pelayanan primer.
CPMK-2	Menerapkan pendekatan keluarga dan siklus kehidupan dalam perencanaan serta pelaksanaan asuhan kebidanan berbasis keluarga dan kesinambungan layanan.
CPMK-3	Menganalisis data KIA dan surveilans untuk pemetaan masalah, penetapan prioritas, serta perencanaan intervensi berbasis bukti.
CPMK-4	Merancang dan mengelola penyelenggaraan layanan KIA berbasis komunitas (Posyandu/UKBM dan layanan terpadu) termasuk pembinaan kader dan jejaring rujukan.
CPMK-5	Melaksanakan KIE/promosi kesehatan dan intervensi gizi ibu–bayi–balita di komunitas dengan strategi perubahan perilaku yang terukur.
CPMK-6	Melakukan edukasi, konseling, dan tindak lanjut layanan kesehatan reproduksi remaja serta keluarga berencana di komunitas secara berpusat pada klien.
CPMK-7	Menyusun strategi pencegahan–penanggulangan masalah KIA prioritas, kesiapsiagaan rujukan, kolaborasi lintas sektor, serta monitoring-evaluasi program.

Matriks CPL–CPMK

CPMK ↓ / CPL →	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6
CPMK-1	✓					✓
CPMK-2			✓		✓	
CPMK-3	✓	✓				✓
CPMK-4	✓			✓		
CPMK-5		✓			✓	
CPMK-6			✓		✓	
CPMK-7		✓		✓		✓

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran adalah bagian penting dalam sebuah buku ajar karena mereka menentukan apa yang diharapkan akan dicapai oleh pembelajar setelah menggunakan buku tersebut. Berikut adalah perbedaan antara keduanya:

Tujuan Intruksional:

Setelah mempelajari Bab 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengimplementasikan upaya pencegahan anemia, Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan stunting pada ibu, bayi, dan balita di komunitas melalui pendekatan skrining, intervensi berbasis keluarga, serta strategi promosi kesehatan yang terukur.

Tujuan ini mencakup kemampuan kognitif (analisis data dan konsep gizi), psikomotor (skrining dan pemantauan pertumbuhan), serta afektif (sikap profesional dan pemberdayaan keluarga dalam konteks pelayanan kebidanan komunitas).

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari Bab 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran sebagai berikut:

Capaian Pembelajaran Utama (CPMK Utama: CPMK-5)

Mahasiswa mampu melaksanakan KIE/promosi kesehatan dan intervensi gizi ibu, bayi, dan balita di komunitas dengan strategi perubahan perilaku yang terukur dalam upaya pencegahan anemia, Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan stunting.

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK)

Sub-CPMK 8.1

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep anemia, KEK, dan stunting pada ibu, bayi, dan balita di komunitas
- Mengidentifikasi faktor risiko anemia, KEK, dan stunting berdasarkan determinan sosial dan data pertumbuhan masyarakat
- Melakukan skrining anemia, KEK, dan stunting menggunakan metode pemeriksaan sederhana di Posyandu dan Puskesmas
- Menginterpretasikan hasil pemeriksaan Hb, LILA, antropometri, dan grafik pertumbuhan WHO secara tepat
- Menganalisis data KIA, surveilans gizi, dan data pertumbuhan untuk pemetaan masalah gizi di wilayah kerja

- Mengidentifikasi kelompok keluarga dengan risiko tinggi anemia, KEK, dan stunting di komunitas

Sub-CPMK 8.2

Mahasiswa mampu:

- Menyusun paket intervensi gizi berbasis keluarga untuk pencegahan anemia, KEK, dan stunting
- Merancang edukasi gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita sesuai kebutuhan komunitas
- Menyusun strategi perubahan perilaku melalui KIE dan promosi kesehatan berbasis budaya lokal
- Menyusun rencana pemantauan pertumbuhan dan tindak lanjut kasus gizi risiko tinggi
- Menentukan mekanisme rujukan pada kasus anemia berat, KEK, dan stunting yang memerlukan penanganan lanjutan
- Melakukan monitoring dan evaluasi sederhana terhadap program gizi ibu dan anak di komunitas

Capaian Pembelajaran Pendukung (CPMK Penguat: CPMK-3 dan CPMK-7)

Mahasiswa juga diharapkan mampu:

- Menganalisis data KIA dan surveilans gizi untuk menentukan prioritas masalah kesehatan di komunitas
- Menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan masalah gizi ibu dan anak berbasis bukti
- Melakukan kolaborasi lintas sektor dengan kader, Posyandu, Puskesmas, dan pemerintah desa dalam program pencegahan stunting
- Menunjukkan kemampuan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program gizi komunitas secara sederhana
- Menunjukkan sikap profesional, komunikatif, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan anak dalam pelayanan kebidanan komunitas

Indikator Ketercapaian Pembelajaran

Untuk memastikan capaian pembelajaran tercapai, indikator yang digunakan meliputi:

- Ketepatan dalam menjelaskan konsep anemia, KEK, dan stunting
- Kemampuan melakukan skrining dan interpretasi hasil pemeriksaan gizi secara tepat
- Ketepatan dalam menganalisis data pertumbuhan dan surveilans gizi komunitas

- Kemampuan menentukan prioritas masalah gizi berdasarkan data wilayah kerja
- Kemampuan menyusun intervensi gizi dan strategi KIE berbasis keluarga
- Ketepatan dalam merencanakan pemantauan pertumbuhan dan rujukan kasus risiko tinggi
- Kemampuan mengaitkan konsep gizi komunitas dengan kasus nyata di Posyandu dan Puskesmas

Capaian Akhir Bab

Pada akhir pembelajaran Bab 8, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melakukan skrining, analisis masalah, intervensi, edukasi, serta monitoring program gizi ibu dan anak di komunitas. Mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan pelayanan kebidanan berbasis keluarga dalam upaya pencegahan anemia, KEK, dan stunting secara promotif, preventif, dan berkesinambungan di tingkat pelayanan primer dan komunitas.

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada Bab 1 ini, mahasiswa mampu:

Aspek Pengetahuan (Knowledge)

- Menjelaskan konsep dasar gizi ibu, bayi, dan balita dalam konteks kebidanan komunitas.
- Menguraikan determinan sosial yang memengaruhi anemia, KEK, dan stunting.
- Menjelaskan kebijakan dan program nasional terkait gizi ibu dan anak.

Aspek Analisis (Higher Order Thinking Skills)

- Menganalisis data KIA dan surveilans pertumbuhan untuk mengidentifikasi risiko anemia, KEK, dan stunting.
- Menginterpretasikan hasil skrining hemoglobin (Hb), Lingkar Lengan Atas (LILA), dan pengukuran antropometri balita.
- Menentukan prioritas masalah gizi berdasarkan data komunitas.

Aspek Keterampilan (Skill)

- Melakukan skrining anemia, KEK, dan pemantauan pertumbuhan sesuai standar pelayanan komunitas.
- Menyusun paket intervensi gizi berbasis keluarga yang meliputi edukasi, suplementasi, dan rujukan.
- Merancang dan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan strategi perubahan perilaku yang terukur.

Aspek Sikap Profesional (Attitude & Responsibility)

- Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pemberdayaan keluarga dan komunitas.
- Mengintegrasikan kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan intervensi gizi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi program gizi secara sistematis dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Buku ajar *Kebidanan Komunitas: Posyandu, KIA, dan Pelayanan Berbasis Keluarga* disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi S1 Kebidanan dalam memahami dan menerapkan pelayanan kesehatan ibu dan anak berbasis komunitas secara komprehensif. Materi dalam buku ini berfokus pada upaya pencegahan anemia, Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan stunting melalui pendekatan promotif, preventif, deteksi dini, intervensi gizi, serta pemberdayaan keluarga di tingkat komunitas. Penyusunan buku didasarkan pada perkembangan kebijakan nasional kesehatan ibu dan anak, pelayanan Posyandu dan KIA, serta pendekatan Outcome Based Education (OBE) yang menekankan kemampuan analisis data, pengambilan keputusan, komunikasi, dan implementasi intervensi berbasis bukti dalam praktik kebidanan komunitas.

Buku ajar *Kebidanan Komunitas: Posyandu, KIA, dan Pelayanan Berbasis Keluarga* disusun untuk membekali mahasiswa kebidanan dengan kompetensi dalam menganalisis masalah gizi ibu, bayi, dan balita berbasis data komunitas. Melalui buku ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi risiko anemia, Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan stunting melalui skrining, surveilans pertumbuhan, serta analisis data kesehatan ibu dan anak. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk mampu menyusun paket intervensi gizi dan strategi promosi kesehatan berbasis keluarga sesuai kebutuhan masyarakat.

Buku ini juga bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menggunakan strategi perubahan perilaku yang terukur dan aplikatif di komunitas. Mahasiswa diharapkan mampu memberikan konseling gizi, melakukan edukasi kesehatan kepada keluarga, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program kesehatan ibu dan anak secara berkesinambungan. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan penerapan asuhan kebidanan komunitas secara nyata dan berbasis bukti.

Sasaran utama buku ini adalah mahasiswa Program Studi S1 Kebidanan sebagai pedoman pembelajaran pada mata kuliah *Kebidanan Komunitas*. Selain itu, buku ini

juga dapat digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah, bidan praktik komunitas, serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan Posyandu dan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Materi yang disajikan diharapkan mampu mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam upaya promotif dan preventif di tingkat komunitas.

Isi buku membahas konsep dan praktik kebidanan komunitas dengan fokus pada pelayanan Posyandu, program KIA, dan pendekatan berbasis keluarga. Materi meliputi konsep dasar kebidanan komunitas, gizi ibu dan anak, pencegahan anemia, KEK, dan stunting, skrining dan analisis data pertumbuhan, strategi intervensi dan promosi kesehatan, kolaborasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi program komunitas. Buku ini disusun menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE) melalui kombinasi penjelasan teori, studi kasus komunitas, analisis data KIA, latihan pemetaan masalah, refleksi praktik kebidanan, dan penugasan berbasis proyek komunitas sehingga mendukung pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan aplikatif.

Uraian Materi

Masalah gizi ibu, bayi, dan balita di komunitas merupakan tantangan kesehatan masyarakat yang bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, ekonomi, budaya, dan akses pelayanan kesehatan. Anemia pada ibu hamil, Kekurangan Energi Kronis (KEK), serta stunting pada balita tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menentukan kualitas generasi mendatang. Dalam konteks kebidanan komunitas, bidan memiliki peran strategis dalam melakukan skrining risiko, analisis data pertumbuhan, serta penyusunan intervensi gizi berbasis keluarga melalui pelayanan Posyandu dan program KIA. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep gizi, deteksi dini, promosi kesehatan, serta monitoring dan evaluasi program menjadi landasan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi secara terukur dan berkelanjutan.

A. Konsep Dasar Gizi dalam Pelayanan Kebidanan Komunitas

1. Determinan sosial gizi ibu dan anak di komunitas

Gizi ibu dan anak tidak hanya dipengaruhi oleh asupan pangan dan pelayanan kesehatan semata, tetapi juga oleh determinan sosial yang lebih luas. Determinan sosial kesehatan didefinisikan sebagai kondisi di mana orang lahir, tumbuh, bekerja, hidup, dan usia tua, termasuk sistem kesehatan yang tersedia di komunitas tersebut, yang secara kolektif memengaruhi status gizi ibu dan anak (tidak hanya individu) dan berkontribusi terhadap kerentanan terhadap masalah seperti anemia, Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan stunting, bukan akibat pilihan individu semata tetapi juga kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang melingkupinya (Taher et al., 2025). Gizi ibu dan anak tidak hanya dipengaruhi oleh asupan pangan dan pelayanan kesehatan semata, tetapi juga oleh determinan sosial yang lebih luas.

Beberapa faktor sosial utama yang memengaruhi gizi ibu dan anak di komunitas meliputi:

- a. Status ekonomi keluarga dan akses pangan bergizi: Keluarga dengan tingkat pendapatan rendah sering mengalami keterbatasan dalam memperoleh makanan yang cukup dan beragam secara nutrien, sehingga meningkatkan risiko malnutrisi pada ibu hamil dan anak balita. Akses ekonomi ini juga berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengakses layanan kesehatan profesional. (Indrastuty & Pujiyanto, 2014).
- b. Pendidikan dan literasi kesehatan ibu: Ibu dengan tingkat pendidikan dan literasi kesehatan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan lebih baik mengenai kebutuhan gizi, teknik pemberian makanan yang adekuat, serta

pemahaman pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pemantauan tumbuh kembang balita. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman ini berdampak pada praktik pemberian makan yang kurang optimal di keluarga (Taher et al., 2025).

- c. Lingkungan sosial dan budaya: Norma budaya dalam praktik pemberian makan, nilai-nilai keluarga tentang makanan, serta praktik tradisional pemberian makanan dapat jadi penentu apakah keluarga menerapkan pola makan yang mendukung atau malah menghambat terpenuhinya kebutuhan gizi ibu dan anak. Beberapa penelitian menemukan bahwa budaya makan tertentu memiliki hubungan signifikan dengan kejadian stunting di beberapa komunitas (Sarilisnawati et al., 2022).
- d. Akses terhadap layanan kesehatan dasar dan sanitasi lingkungan: Ketersediaan fasilitas kesehatan yang dekat dan mudah dijangkau, ketersediaan sarana sanitasi yang layak, serta akses air bersih merupakan bagian dari determinan yang secara tidak langsung memengaruhi risiko gangguan gizi. Keluarga yang kurang memiliki akses ke Posyandu atau Puskesmas cenderung mengalami hambatan dalam penanganan masalah gizi, serta skrining dan intervensi dini.
- e. Konteks pekerjaan dan status sosial ekonomi ibu: Ibu yang bekerja dengan jam kerja panjang atau pekerjaan informal dengan pendapatan rendah cenderung memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas untuk fokus pada makanan rumah tangga bergizi atau pemantauan kesehatan anak. Hal ini juga berpengaruh terhadap interaksi keluarga dan pola asuhan yang mendukung kebutuhan gizi anak (Indrastuty & Pujiyanto, 2014).

Kesemua faktor sosial ini bekerja secara terintegrasi dan saling memengaruhi, sehingga pendekatan penanggulangan masalah gizi di komunitas harus melibatkan strategi multisektoral yang melampaui pelayanan medis saja. Strategi intervensi yang efektif harus mencakup peningkatan pendidikan gizi, pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan akses layanan kesehatan di tingkat komunitas, serta pendekatan sensitif budaya terhadap praktik pemberian makan di keluarga. Hal ini menekankan bahwa gizi ibu dan anak merupakan isu pembangunan sosial yang perlu ditangani secara bersama oleh bidan, keluarga, serta pemangku kebijakan kesehatan masyarakat.

2. Siklus kehidupan dan pengaruh gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan fase krusial yang dimulai sejak konsepsi hingga anak berusia dua tahun dan dikenal sebagai *window of opportunity* karena masa ini merupakan periode paling determinan dalam membentuk pertumbuhan, perkembangan saraf, dan kesehatan jangka panjang seseorang. Masa ini terdiri atas sekitar 270 hari selama kehamilan dan 730 hari setelah lahir, di mana proses tumbuh dan berkembang organ dan jaringan tubuh berlangsung sangat cepat serta membutuhkan asupan nutrisi yang optimal. Kekurangan nutrisi dalam periode ini dapat berdampak jangka panjang yang tidak mudah diperbaiki di kemudian hari (nutrien kunci selama 1000 HPK) (Anjani et al., 2024).

Pada masa kehamilan, status gizi ibu menjadi penentu utama terhadap pertumbuhan janin. Asupan nutrisi yang adekuat mendukung pembentukan organ, fungsi sistem imun, serta pembentukan struktur otak janin. Kekurangan nutrisi mikro seperti zat besi, folat, dan asam lemak esensial dapat mengganggu perkembangan tersebut dan meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat lahir rendah, serta akan memengaruhi kemampuan belajar dan daya tahan tubuh anak di kemudian hari. Bahkan perkembangan organ seperti sistem pernafasan pun dipengaruhi oleh status nutrisi ibu, di mana gangguan nutrisi selama kehamilan dapat berdampak pada risiko penyakit seperti hipertensi pulmonal pada neonatus (hubungan nutrisi ibu dan organ) (Luca et al., 2026).

Setelah bayi lahir, fase ASI eksklusif selama 0–6 bulan menjadi dasar pemenuhan nutrisi awal yang penting bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan imun. ASI memberikan kombinasi ideal energi, protein, dan mikronutrien serta antibodi yang membantu mencegah infeksi. Ketika bayi memasuki masa MP-ASI (6–24 bulan), pemberian makanan pendamping yang tepat dan bergizi seimbang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan mikronutrien yang meningkat seiring pertumbuhan. Kurangnya asupan nutrisi esensial dalam periode ini berkaitan langsung dengan risiko gagal tumbuh (*stunting*), gangguan kognitif, dan penurunan kemampuan belajar (nutrisi periode MP-ASI) (Likhar & Patil, 2022).

Secara fisiologis, periode 1000 HPK adalah saat otak berkembang paling cepat dibandingkan periode lain dalam hidup. Nutrien seperti protein, zat besi, asam lemak omega-3, vitamin A, D, dan folat sangat penting untuk perkembangan sistem saraf pusat. Kekurangan nutrisi ini selain berdampak pada fisik anak, juga berhubungan dengan keterlambatan perkembangan kognitif, gangguan imunitas, serta peningkatan risiko penyakit kronis di kemudian hari

seperti obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular jika gizi buruk terjadi dalam periode kritis ini.

Dalam konteks komunitas, bukti menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman keluarga terkait pentingnya pemenuhan gizi sejak kehamilan hingga usia dua tahun dapat menurunkan kejadian stunting secara signifikan. Edukasi dan intervensi gizi yang tepat pada 1000 HPK tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik yang optimal tetapi juga keterampilan belajar dan produktivitas anak di masa yang akan datang (*stunting prevention through HPK education*) (Hasneli et al., 2023).

Secara keseluruhan, pemenuhan gizi yang optimal selama 1000 HPK menjadi dasar kesehatan dan perkembangan anak sepanjang hayat. Kegagalan memenuhi kebutuhan nutrisi pada periode ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak hanya bersifat klinis tetapi juga sosial dan ekonomi, sehingga intervensi dini dan komprehensif berbasis keluarga menjadi strategi penting dalam pelayanan kebidanan komunitas untuk mencegah malnutrisi kronis termasuk stunting.

3. Peran bidan dalam pelayanan gizi berbasis keluarga

Pelayanan gizi berbasis keluarga merupakan pendekatan yang menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi ibu dan anak. Dalam konteks kebidanan komunitas, bidan tidak hanya berfokus pada individu (ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita), tetapi juga berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku kesehatan dalam keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *continuum of care* dan siklus kehidupan, khususnya pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang terbukti sebagai periode kritis dalam pencegahan stunting dan gangguan tumbuh kembang (WHO, 2025b).

a. Peran promotif

Pada aspek promotif, bidan berperan dalam meningkatkan literasi gizi keluarga melalui:

- 1) Edukasi tentang gizi seimbang bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
- 2) Konseling pola makan berbasis pangan lokal dan bergizi seimbang.
- 3) Edukasi pentingnya suplementasi zat besi dan asam folat pada remaja dan ibu hamil.
- 4) Promosi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif selama 6 bulan.

Edukasi dilakukan melalui kelas ibu hamil, kelas ibu balita, kunjungan rumah, dan kegiatan di Posyandu. Pendekatan keluarga bertujuan agar suami dan anggota keluarga lain turut mendukung praktik gizi yang optimal. Strategi ini

sesuai dengan rekomendasi *family-centered care* dalam pelayanan kesehatan primer

b. Peran preventif

Dalam upaya preventif, bidan melakukan deteksi dini risiko masalah gizi melalui:

- 1) Skrining anemia pada remaja dan ibu hamil.
- 2) Pemantauan kenaikan berat badan ibu hamil sesuai standar.
- 3) Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita menggunakan kurva WHO.
- 4) Identifikasi faktor risiko sosial seperti kemiskinan, ketahanan pangan rendah, dan sanitasi buruk.

Bidan juga berperan dalam mendorong kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), suplementasi kalsium, serta pemberian vitamin A pada balita sesuai program nasional. Upaya ini mendukung target percepatan penurunan stunting sebagaimana tertuang dalam kebijakan nasional

c. Peran kuratif dan kolaboratif

Pada kasus gizi kurang, gizi buruk, atau ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK), bidan melakukan:

- 1) Tatalaksana awal sesuai kewenangan.
- 2) Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut bila diperlukan.
- 3) Koordinasi dengan tenaga gizi, dokter, dan kader kesehatan.

Kolaborasi lintas sektor sangat penting, termasuk dengan program bantuan sosial, ketahanan pangan desa, dan pemberdayaan perempuan. Pelayanan gizi berbasis keluarga tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan sistem kesehatan dan lingkungan sosial yang mendukung.

d. Peran advokasi dan pemberdayaan

Bidan komunitas juga berperan sebagai advokat kesehatan masyarakat dengan:

- 1) Menggerakkan kader Posyandu.
- 2) Menginisiasi program dapur sehat berbasis keluarga.
- 3) Mendorong pemanfaatan pekarangan untuk sumber pangan bergizi.
- 4) Memberikan konseling perubahan perilaku berbasis budaya lokal.

Pendekatan pemberdayaan keluarga terbukti efektif dalam meningkatkan praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA) serta menurunkan risiko stunting

Dengan demikian, peran bidan dalam pelayanan gizi berbasis keluarga bersifat komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif, kolaboratif, dan advokatif. Optimalisasi peran ini sangat menentukan keberhasilan peningkatan

status gizi ibu dan anak di komunitas, terutama dalam mendukung pencapaian target penurunan stunting nasional dan global.

4. Kebijakan nasional terkait gizi ibu dan anak (program KIA dan Posyandu)

Kebijakan nasional terkait gizi ibu dan anak di Indonesia berfokus pada pencegahan anemia pada ibu hamil, Kekurangan Energi Kronis (KEK), serta stunting pada anak. Pemerintah menetapkan kebijakan percepatan penurunan stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang menekankan pendekatan intervensi gizi secara terpadu dan lintas sektor. Kebijakan ini menargetkan kelompok prioritas seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah lima tahun. Strategi nasional tersebut menekankan pentingnya intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai periode kritis untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*Percepatan Penurunan Stunting*, 2021).

a. Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup pemantauan kesehatan ibu sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga pertumbuhan dan perkembangan bayi serta balita. Dalam konteks gizi, program ini meliputi pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, pemantauan status gizi ibu selama kehamilan, promosi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif, serta pemantauan pertumbuhan anak. Implementasi program KIA didukung oleh penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) yang berfungsi sebagai alat pencatatan kesehatan sekaligus media edukasi bagi keluarga dalam memantau kesehatan ibu dan anak sejak kehamilan hingga anak usia enam tahun

b. Program Posyandu

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat komunitas. Posyandu menyediakan layanan seperti penimbangan balita, pemantauan pertumbuhan melalui Kartu Menuju Sehat (KMS), pemberian vitamin A, penyuluhan gizi, serta deteksi dini masalah gizi seperti stunting. Melalui kegiatan Posyandu, tenaga kesehatan dan kader dapat memantau pertumbuhan anak secara berkala dan memberikan edukasi gizi kepada keluarga sehingga masalah gizi dapat dideteksi dan ditangani lebih awal.

Secara keseluruhan, integrasi program KIA dan Posyandu menjadi strategi utama pemerintah dalam meningkatkan status gizi ibu dan anak di tingkat komunitas serta mendukung upaya nasional dalam penurunan stunting.

B. Identifikasi dan Skrining Risiko Anemia pada Ibu Hamil dan Remaja Putri

1. Definisi dan klasifikasi anemia dalam kehamilan

Anemia dalam kehamilan adalah kondisi kadar hemoglobin (Hb) di bawah nilai normal akibat penurunan kapasitas darah dalam mengangkut oksigen. Berdasarkan standar World Health Organization, anemia pada ibu hamil ditetapkan apabila kadar Hb **< 11 g/dL** (Aldakhil et al., 2025).

Klasifikasi anemia berdasarkan kadar Hb:

- a. Ringan: 10,0–10,9 g/dL
- b. Sedang: 7,0–9,9 g/dL
- c. Berat: < 7,0 g/dL

Perubahan fisiologis kehamilan seperti hemodilusi menyebabkan penurunan Hb, sehingga interpretasi harus mempertimbangkan trimester kehamilan (Khezri et al., 2025).

2. Faktor risiko anemia di komunitas

Anemia pada ibu hamil dan remaja putri dipengaruhi oleh faktor multifaktorial, meliputi aspek biologis, sosial, dan lingkungan. Faktor risiko utama adalah defisiensi zat besi akibat asupan yang tidak adekuat dan peningkatan kebutuhan selama kehamilan.

Faktor risiko utama di komunitas:

- a. Asupan zat besi rendah
- b. Kepatuhan konsumsi tablet tambah darah rendah
- c. Jarak kehamilan < 2 tahun
- d. Infeksi (cacingan, malaria)
- e. Status sosial ekonomi rendah
- f. Paritas tinggi dan kunjungan ANC kurang

Anemia juga berkaitan dengan determinan sosial seperti pendidikan rendah dan akses layanan kesehatan yang terbatas (Azzam et al., 2025).

3. Teknik skrining anemia di Posyandu dan Puskesmas

Skrining anemia merupakan bagian dari pelayanan kesehatan primer yang dilakukan secara rutin pada remaja putri dan ibu hamil. Metode utama adalah pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) menggunakan alat portabel atau laboratorium.

Langkah skrining:

- a. Anamnesis (pola makan, riwayat kesehatan)
- b. Pemeriksaan fisik (konjungtiva pucat, lemah)
- c. Pemeriksaan Hb
- d. Pencatatan dalam buku KIA

Rekomendasi terbaru menyarankan skrining dilakukan minimal dua kali selama kehamilan (awal dan trimester II/III) (Ubom et al., 2025).

4. Interpretasi hasil pemeriksaan Hb

Interpretasi Hb dilakukan dengan membandingkan hasil dengan standar WHO:

Kadar Hb	Interpretasi
≥ 11 g/dL	Normal
10,0–10,9 g/dL	Anemia ringan
7,0–9,9 g/dL	Anemia sedang
$< 7,0$ g/dL	Anemia berat

Interpretasi ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis, seperti pemberian suplementasi zat besi, terapi lanjutan, atau rujukan (Aldakhil et al., 2025).

5. Analisis data anemia berbasis wilayah kerja

Data anemia dari Posyandu dan Puskesmas dianalisis untuk mengetahui prevalensi dan distribusi kasus dalam wilayah kerja. Analisis ini bertujuan untuk:

- Menentukan wilayah dengan risiko tinggi
- Menilai cakupan program TTD
- Mengevaluasi efektivitas intervensi

Pendekatan berbasis data memungkinkan perencanaan program yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (*evidence-based practice*) (Rahayu et al., 2024).

6. Pemetaan kelompok risiko tinggi

Pemetaan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok rentan anemia, seperti:

- Remaja putri
- Ibu hamil dengan KEK
- Ibu dengan jarak kehamilan dekat
- Keluarga dengan status sosial ekonomi rendah

Pemetaan berbasis komunitas membantu tenaga kesehatan dalam menentukan prioritas intervensi seperti suplementasi, edukasi gizi, dan kunjungan rumah. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan anemia secara berkelanjutan (Azzam et al., 2025).

C. Identifikasi dan Deteksi Dini Kekurangan Energi Kronis (KEK)

Kekurangan Energi Kronis (KEK) merupakan masalah gizi yang masih banyak ditemukan pada wanita usia subur (WUS) dan ibu hamil, terutama di negara berkembang. KEK berdampak pada meningkatnya risiko komplikasi kehamilan, persalinan, serta kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR). Oleh karena itu, identifikasi

dan deteksi dini KEK menjadi bagian penting dalam pelayanan kebidanan komunitas untuk mendukung perbaikan status gizi ibu dan anak.

1. Konsep KEK pada ibu hamil dan WUS

KEK adalah kondisi kekurangan asupan energi dan protein dalam jangka waktu lama yang ditandai dengan status gizi kurang. Pada ibu hamil, KEK dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, anemia, serta meningkatkan risiko persalinan prematur dan BBLR.

Pada wanita usia subur (WUS), KEK juga menjadi faktor risiko sebelum kehamilan (*preconception risk*), yang dapat memengaruhi kualitas kehamilan berikutnya. Oleh karena itu, intervensi gizi sebaiknya dimulai sejak remaja dan WUS. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa KEK berkaitan erat dengan pola makan tidak adekuat, status sosial ekonomi rendah, serta kurangnya akses terhadap pelayanan Kesehatan (Organization, 2024).

2. Pengukuran LILA dan interpretasi

Deteksi KEK di komunitas dilakukan dengan pengukuran **Lingkar Lengan Atas (LILA)** yang merupakan metode sederhana, cepat, dan efektif untuk menilai status gizi ibu.

Interpretasi LILA:

- a. **< 23,5 cm** → Berisiko KEK
- b. **≥ 23,5 cm** → Status gizi normal

Pengukuran LILA memiliki keunggulan karena tidak dipengaruhi oleh usia kehamilan dan dapat digunakan di fasilitas kesehatan dasar maupun Posyandu. Penggunaan LILA sebagai indikator KEK telah direkomendasikan secara luas karena memiliki sensitivitas yang baik dalam memprediksi risiko BBLR dan komplikasi kehamilan (Byrum et al., 2023).

3. Analisis faktor penyebab KEK berbasis keluarga

KEK tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan lingkungan. Pendekatan berbasis keluarga penting dalam mengidentifikasi penyebab utama KEK.

Faktor penyebab KEK antara lain:

- a. Pola konsumsi makanan yang tidak seimbang
- b. Ketahanan pangan keluarga rendah
- c. Pengetahuan gizi keluarga yang kurang
- d. Pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga
- e. Beban kerja ibu yang tinggi

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga lebih efektif dalam meningkatkan status gizi ibu dibandingkan pendekatan individual (Shrestha et al., 2022).

4. Penggunaan data KIA untuk identifikasi risiko KEK

Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan sumber data penting dalam identifikasi risiko KEK. Data yang dapat digunakan meliputi:

- a. Hasil pengukuran LILA
- b. Berat badan ibu selama kehamilan
- c. Riwayat kehamilan sebelumnya
- d. Catatan kunjungan antenatal

Melalui pencatatan yang sistematis, tenaga kesehatan dapat memantau perubahan status gizi ibu secara berkala serta mendeteksi risiko KEK sejak dini. Pemanfaatan data KIA juga mendukung pendekatan *continuity of care*, sehingga intervensi dapat dilakukan secara berkelanjutan dari masa kehamilan hingga pasca persalinan (Kemenkes RI, 2020).

5. Pemetaan kasus KEK di komunitas

Pemetaan kasus KEK dilakukan untuk mengetahui distribusi dan prevalensi KEK di suatu wilayah kerja. Data diperoleh dari Posyandu, Puskesmas, serta laporan surveilans gizi masyarakat.

Tujuan pemetaan:

- a. Mengidentifikasi wilayah dengan kasus KEK tinggi
- b. Menentukan kelompok prioritas intervensi
- c. Merencanakan program gizi berbasis komunitas

Pemetaan berbasis wilayah memungkinkan tenaga kesehatan melakukan intervensi yang lebih terarah, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), edukasi gizi keluarga, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan. Pendekatan ini juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) dalam program kesehatan Masyarakat (Organization, 2025).

D. Skrining dan Pemantauan Risiko Stunting pada Bayi dan Balita

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan panjang/tinggi badan menurut umur berada di bawah standar (< -2 SD). Kondisi ini mencerminkan kekurangan gizi jangka panjang yang terjadi sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak. Skrining dan pemantauan stunting menjadi bagian penting dalam pelayanan kebidanan komunitas untuk mendukung deteksi dini dan intervensi berbasis keluarga.

1. Konsep stunting dan dampak jangka Panjang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta stimulasi yang tidak optimal selama periode 1000 HPK. Dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif, imunitas, serta produktivitas saat dewasa.

Penelitian menunjukkan bahwa stunting berhubungan dengan penurunan kemampuan belajar dan peningkatan risiko penyakit tidak menular di masa depan. Selain itu, stunting juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia secara nasional (Muhammad et al., 2025).

2. Pengukuran antropometri (BB, TB/PB, Z-score)

Skrining stunting dilakukan melalui pengukuran antropometri yang meliputi berat badan (BB), panjang/tinggi badan (PB/TB), serta perhitungan Z-score berdasarkan standar WHO.

Indikator utama:

- a. TB/U → stunting
- b. BB/U → underweight
- c. BB/TB → wasting

Pengukuran harus dilakukan dengan teknik yang benar agar menghasilkan data yang valid untuk diagnosis dan pemantauan (WHO & UNICEF, 2019).

3. Interpretasi grafik pertumbuhan WHO

Grafik pertumbuhan WHO digunakan untuk menilai status pertumbuhan anak secara longitudinal. Interpretasi berdasarkan Z-score:

- a. ≥ -2 SD → normal
- b. < -2 SD → stunting
- c. < -3 SD → stunting berat

Di Indonesia, grafik ini diadaptasi dalam KMS (Kartu Menuju Sehat) yang digunakan di Posyandu untuk pemantauan rutin (WHO, 2025a).

4. Analisis data pertumbuhan Posyandu

Data Posyandu (BB, TB/PB, KMS) digunakan untuk:

- a. Menentukan status gizi balita
- b. Mengidentifikasi tren pertumbuhan
- c. Menentukan wilayah risiko tinggi

Analisis ini penting sebagai dasar perencanaan intervensi gizi di tingkat komunitas (Kemenkes, 2020).

5. Identifikasi faktor keluarga penyebab stunting

Faktor penyebab stunting sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga, antara lain:

- a. Pola pemberian makan (jenis, jumlah, frekuensi)
- b. Status gizi ibu
- c. Sanitasi lingkungan
- d. Tingkat pendidikan dan ekonomi keluarga

Penelitian oleh Dian Rahmawati menunjukkan bahwa pola pemberian makan memiliki hubungan signifikan dengan kejadian stunting pada balita,

terutama terkait kualitas dan frekuensi makanan yang diberikan (Rahmawati et al., 2024).

6. Surveilans pertumbuhan berbasis komunitas

Surveilans pertumbuhan adalah pemantauan status gizi secara berkelanjutan melalui Posyandu dan Puskesmas. Kegiatan ini melibatkan kader, bidan, dan keluarga dalam pencatatan serta pelaporan data pertumbuhan anak. Tujuan surveilans:

- a. Deteksi dini stunting
- b. Pemantauan tren prevalensi
- c. Dasar pengambilan kebijakan kesehatan

Pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan cakupan pemantauan dan intervensi gizi. Skrining dan pemantauan stunting merupakan langkah penting dalam pelayanan kebidanan komunitas. Penggunaan antropometri, grafik WHO, serta analisis data Posyandu memungkinkan deteksi dini gangguan pertumbuhan. Faktor keluarga memiliki peran dominan dalam kejadian stunting, sehingga pendekatan berbasis keluarga dan komunitas menjadi strategi utama dalam pencegahan.

E. Analisis Data KIA dan Surveilans Gizi untuk Penetapan Prioritas

Analisis data Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta surveilans gizi merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data kesehatan untuk mengidentifikasi masalah utama di komunitas. Dalam praktik kebidanan komunitas, kemampuan menganalisis data menjadi kompetensi penting karena menjadi dasar dalam menentukan prioritas masalah dan merancang intervensi berbasis bukti (*evidence-based practice*). Pendekatan ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Sumber data KIA dan gizi (Posyandu, PWS-KIA, e-PPGBM)

Data KIA dan gizi di tingkat komunitas berasal dari beberapa sistem pencatatan dan pelaporan yang saling terintegrasi (Kemenkes, 2021), yaitu:

a. Posyandu

Posyandu merupakan sumber data primer di masyarakat yang dikelola oleh kader dengan pendampingan tenaga kesehatan. Data yang dikumpulkan meliputi:

- 1) Berat badan (BB) dan tinggi/panjang badan (TB/PB) balita
- 2) Status gizi (stunting, wasting, underweight)
- 3) Cakupan imunisasi dan vitamin A
- 4) Data ibu hamil dan menyusui

Data ini digunakan untuk pemantauan pertumbuhan dan deteksi dini masalah gizi.

b. PWS-KIA (Pemantauan Wilayah Setempat KIA)

PWS-KIA merupakan sistem monitoring cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja Puskesmas, meliputi:

- 1) Kunjungan antenatal (K1, K4/K6)
- 2) Persalinan oleh tenaga kesehatan
- 3) Pelayanan nifas dan neonatal
- 4) Deteksi risiko tinggi ibu dan bayi

PWS-KIA membantu dalam memantau kinerja program dan kesenjangan pelayanan.

c. e-PPGBM

e-PPGBM adalah sistem elektronik nasional untuk pencatatan dan pelaporan status gizi masyarakat secara real-time. Data yang tersedia antara lain:

- 1) Prevalensi stunting, wasting, dan underweight
- 2) Identitas sasaran (by name by address)
- 3) Riwayat pemantauan pertumbuhan

Integrasi ketiga sumber data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kesehatan dan gizi masyarakat.

2. Teknik analisis sederhana data komunitas

Analisis data komunitas dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Teknik analisis sederhana yang umum digunakan dalam praktik kebidanan komunitas meliputi:

a. Analisis Deskriptif

- 1) Menghitung jumlah kasus (misalnya jumlah balita stunting)
- 2) Menentukan distribusi berdasarkan umur, wilayah, atau kelompok risiko

b. Prevalensi/Proporsi

Menghitung persentase masalah kesehatan, misalnya:

$$\text{Prevalensi stunting} = \frac{\text{jumlah balita stunting}}{\text{total balita}} \times 100\%$$

c. Analisis Tren

Membandingkan data antar waktu (bulan/tahun) untuk melihat peningkatan atau penurunan kasus

d. Perbandingan Wilayah

Membandingkan antar desa atau Posyandu untuk mengidentifikasi wilayah prioritas

Analisis sederhana ini sangat penting karena mudah dilakukan namun mampu memberikan gambaran situasi kesehatan secara cepat dan akurat (Gordis, 2020) (Friis & Sellers, 2021).

3. Penentuan prioritas masalah gizi

Penentuan prioritas dilakukan karena keterbatasan sumber daya sehingga tidak semua masalah dapat ditangani sekaligus. Prioritas ditentukan berdasarkan beberapa kriteria:

- a. Magnitude (besar masalah) → prevalensi tinggi
- b. Severity (tingkat keparahan) → dampak terhadap kesehatan
- c. Vulnerability (kerentanan kelompok sasaran)
- d. Feasibility (kemungkinan intervensi)

Metode yang sering digunakan:

- a. USG (Urgency, Seriousness, Growth)
- b. Skoring prioritas masalah

Contoh: Jika prevalensi stunting tinggi dan berdampak jangka panjang, maka stunting menjadi prioritas utama (WHO, 2020a).

4. Penyusunan diagnosis komunitas

Diagnosis komunitas adalah rumusan masalah kesehatan berdasarkan hasil analisis data yang mencerminkan kondisi nyata di masyarakat. Diagnosis ini menjadi dasar dalam perencanaan intervensi.

Komponen diagnosis komunitas meliputi:

- a. Masalah kesehatan utama
- b. Kelompok sasaran
- c. Lokasi/wilayah
- d. Faktor penyebab

Contoh diagnosis: "Tingginya prevalensi stunting pada balita di Desa X (35%) berhubungan dengan rendahnya praktik pemberian makan bayi dan anak serta kurangnya pengetahuan gizi ibu."

Diagnosis komunitas harus spesifik, terukur, dan berbasis data (Stanhope & Lancaster, 2020).

5. Perencanaan intervensi berbasis bukti

Perencanaan intervensi dilakukan berdasarkan diagnosis komunitas dengan mengacu pada bukti ilmiah dan kondisi lokal. Intervensi dibagi menjadi:

- a. Intervensi Spesifik (langsung)
 - 1) Suplementasi zat besi
 - 2) Pemberian makanan tambahan (PMT)
 - 3) Edukasi gizi ibu dan keluarga

b. Intervensi Sensitif (tidak langsung)

- 1) Perbaikan sanitasi dan air bersih
- 2) Ketahanan pangan keluarga
- 3) Pemberdayaan ekonomi

Pendekatan berbasis bukti memastikan bahwa intervensi yang dilakukan efektif dalam menurunkan masalah gizi. Integrasi intervensi spesifik dan sensitif terbukti memberikan dampak yang lebih besar dalam perbaikan status gizi Masyarakat (Bhutta, 2020).

F. Penyusunan Paket Intervensi Gizi Berbasis Keluarga

Penyusunan paket intervensi gizi berbasis keluarga merupakan strategi penting dalam pelayanan kebidanan komunitas untuk mengatasi masalah gizi seperti anemia, Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan stunting. Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam perubahan perilaku kesehatan, sehingga intervensi tidak hanya berfokus pada individu tetapi juga pada lingkungan sosial yang memengaruhi status gizi.

1. Prinsip intervensi gizi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif

Intervensi gizi dalam pelayanan kesehatan dilakukan secara komprehensif melalui empat pendekatan utama:

- a. Promotif: peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi (edukasi gizi, penyuluhan)
- b. Preventif: pencegahan masalah gizi (suplementasi, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang)
- c. Kuratif: penanganan kasus gizi (anemia, KEK, stunting)
- d. Rehabilitatif: pemulihan kondisi gizi (PMT, pemantauan lanjutan)

Pendekatan terintegrasi ini terbukti efektif dalam menurunkan masalah gizi di Masyarakat (Bhutta, 2020).

2. Edukasi gizi ibu hamil, menyusui, bayi, dan balita

Edukasi gizi merupakan intervensi utama dalam meningkatkan perilaku kesehatan keluarga. Materi edukasi meliputi:

- a. Ibu hamil: kebutuhan energi, protein, zat besi, dan asam folat
- b. Ibu menyusui: peningkatan kebutuhan gizi dan pentingnya ASI eksklusif
- c. Bayi dan balita: praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), MP-ASI yang adekuat

Edukasi yang berkelanjutan terbukti meningkatkan praktik pemberian makan dan status gizi anak (Ruel, 2021).

3. Intervensi pemberian tablet tambah darah

Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) merupakan strategi utama dalam pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dan ibu hamil.

Program ini mencakup:

- a. Remaja putri: 1 tablet/minggu
- b. Ibu hamil: minimal 90 tablet selama kehamilan

Keberhasilan intervensi dipengaruhi oleh kepatuhan konsumsi, edukasi, serta dukungan keluarga (WHO, 2020b).

4. Strategi perbaikan pola makan keluarga

Perbaikan pola makan keluarga dilakukan melalui pendekatan gizi seimbang dengan memperhatikan:

- a. Keanekaragaman pangan
- b. Frekuensi dan porsi makan
- c. Pemanfaatan pangan lokal bergizi
- d. Pola makan sesuai siklus kehidupan

Pendekatan berbasis keluarga efektif dalam meningkatkan kualitas konsumsi makanan dan status gizi anggota keluarga (Beal, 2021).

5. Pemberdayaan keluarga dalam pencegahan stunting

Pemberdayaan keluarga merupakan strategi penting dalam pencegahan stunting. Kegiatan meliputi:

- a. Edukasi dan konseling gizi
- b. Keterlibatan keluarga dalam pemantauan pertumbuhan
- c. Peningkatan keterampilan pengolahan makanan
- d. Dukungan terhadap praktik ASI eksklusif dan MP-ASI

Pendekatan ini menekankan perubahan perilaku jangka panjang yang berkelanjutan (Rahmawati et al., 2024).

6. Perencanaan rujukan kasus anemia berat, KEK, dan stunting

Rujukan dilakukan pada kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan. Kriteria rujukan meliputi:

- a. Anemia berat ($Hb < 7$ g/dL)
- b. KEK berat (LILA sangat rendah atau komplikasi)
- c. Stunting dengan komplikasi (infeksi, gagal tumbuh berat)

Perencanaan rujukan harus mencakup:

- a. Identifikasi kasus
- b. Koordinasi dengan fasilitas rujukan
- c. Edukasi keluarga
- d. Tindak lanjut pasca rujukan

Sistem rujukan yang baik meningkatkan keberhasilan penanganan kasus gizi (Kemenkes. RI, 2020). Paket intervensi gizi berbasis keluarga merupakan strategi efektif dalam meningkatkan status gizi ibu dan anak. Pendekatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta melibatkan keluarga secara aktif, terbukti mampu menurunkan risiko anemia, KEK, dan stunting. Peran bidan sangat penting dalam edukasi, pendampingan, serta koordinasi intervensi di tingkat komunitas.

G. Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Anemia, KEK, dan Stunting

Monitoring dan evaluasi (M&E) merupakan komponen penting dalam siklus manajemen program kesehatan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks pencegahan anemia, Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan stunting, M&E berfungsi untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi hambatan, serta menjadi dasar perbaikan program secara berkelanjutan.

1. Indikator program gizi ibu dan anak

Indikator merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan program. Indikator program gizi ibu dan anak meliputi:

a. Indikator Input

- 1) Ketersediaan tablet tambah darah (TTD)
- 2) Jumlah tenaga kesehatan dan kader

b. Indikator Proses

- 1) Cakupan kunjungan antenatal (K1, K4/K6)
- 2) Cakupan distribusi TTD
- 3) Cakupan penimbangan balita di Posyandu

c. Indikator Output

- 1) Persentase ibu hamil mengonsumsi ≥ 90 TTD
- 2) Cakupan ASI eksklusif
- 3) Persentase balita yang dipantau pertumbuhannya

d. Indikator Outcome

- 1) Penurunan prevalensi anemia
- 2) Penurunan kasus KEK
- 3) Penurunan prevalensi stunting

Indikator harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*) (Victoria et al., 2022).

2. Sistem pencatatan dan pelaporan

Sistem pencatatan dan pelaporan merupakan bagian penting dalam monitoring program. Di Indonesia, sistem yang digunakan meliputi:

- a. Posyandu → pencatatan KMS dan register balita
- b. PWS-KIA → pelaporan cakupan pelayanan ibu dan anak
- c. e-PPGBM → pelaporan status gizi berbasis elektronik

Data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Digitalisasi melalui e-PPGBM meningkatkan kualitas dan kecepatan pelaporan data gizi (Kemenkes, 2022).

3. Evaluasi keberhasilan intervensi

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah program yang dilaksanakan telah mencapai target yang ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui:

- a. Evaluasi proses → menilai pelaksanaan kegiatan
- b. Evaluasi hasil → menilai pencapaian indikator output
- c. Evaluasi dampak → menilai perubahan status kesehatan

Contoh:

- a. Penurunan angka anemia setelah program TTD
- b. Peningkatan berat badan ibu hamil
- c. Penurunan prevalensi stunting

Evaluasi berbasis data membantu memastikan efektivitas intervensi serta efisiensi penggunaan sumber daya.

4. Kolaborasi lintas sektor (PKK, kader, Puskesmas, desa)

Keberhasilan program gizi tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan kolaborasi lintas sektor. Pihak yang terlibat antara lain:

- a. PKK → edukasi dan pemberdayaan keluarga
- b. Kader Posyandu → pelaksanaan kegiatan di masyarakat
- c. Puskesmas → pembinaan teknis dan pelayanan kesehatan
- d. Pemerintah desa → dukungan kebijakan dan pendanaan

Pendekatan kolaboratif ini dikenal sebagai konvergensi intervensi, yang terbukti efektif dalam penurunan stunting.

5. Perbaikan program berbasis hasil evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan program secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Langkah perbaikan meliputi:

- a. Identifikasi kelemahan program
- b. Penyesuaian strategi intervensi
- c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

d. Penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat

Pendekatan ini memastikan program tetap relevan dan efektif sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

H. Aktivitas 1- Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang ibu hamil usia 23 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 26 minggu, datang ke Posyandu untuk pemeriksaan rutin. Ibu mengeluh sering merasa lemas, pusing, dan kurang nafsu makan sejak beberapa minggu terakhir.

Hasil pemeriksaan: keadaan umum tampak lemah, TD 100/70 mmHg, nadi 96 x/menit, suhu 36,7°C, konjungtiva pucat. Hasil pengukuran LILA 22,5 cm. Pemeriksaan Hb menggunakan alat digital menunjukkan Hb 9,8 g/dL.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa ibu jarang mengonsumsi tablet tambah darah karena merasa mual setelah minum obat. Pola makan sehari-hari didominasi nasi dan lauk sederhana, jarang mengonsumsi protein hewani. Ibu tinggal bersama suami dan mertua, dengan kondisi ekonomi keluarga terbatas.

Berdasarkan data Posyandu, di wilayah tersebut terdapat cukup banyak ibu hamil dengan kondisi anemia dan KEK.

Pertanyaan Diskusi:

1. Apa masalah utama yang dialami ibu pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Berdasarkan konsep faktor penyebab gizi (langsung dan tidak langsung), apa saja faktor yang berkontribusi pada kondisi ibu?
4. Apakah ibu termasuk dalam kategori risiko tinggi? Jelaskan alasan Anda.
5. Apa dampak yang mungkin terjadi jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik pada ibu dan janin?
6. Apa intervensi awal yang dapat dilakukan oleh bidan di tingkat Posyandu/Puskesmas?
7. Bagaimana strategi edukasi yang tepat agar ibu patuh mengonsumsi tablet tambah darah?

I. Aktivitas 2 — Shows

Simulasi / Role Play

Judul Kegiatan:

Simulasi Konseling Gizi pada Ibu Hamil dengan Anemia dan KEK di Posyandu

1. Deskripsi Kegiatan:

Mahasiswa melakukan simulasi (role play) sebagai bidan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil dengan anemia dan risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) di Posyandu. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keterampilan komunikasi, konseling, serta pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan komunitas berbasis keluarga.

2. Skenario Role Play:

Seorang ibu hamil usia 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke Posyandu dengan keluhan mudah lelah dan sering pusing.

Hasil pemeriksaan:

- a. LILA: 22 cm
- b. Hb: 9,5 g/dL
- c. Pola makan kurang protein hewani
- d. Tidak rutin minum tablet tambah darah
- e. Tinggal di keluarga dengan ekonomi rendah

Mahasiswa berperan sebagai bidan yang harus melakukan:

- a. Komunikasi terapeutik
- b. Penyampaian hasil pemeriksaan
- c. Edukasi gizi
- d. Konseling kepatuhan tablet tambah darah
- e. Rencana tindak lanjut

3. Pembagian Peran:

- a. 1 mahasiswa sebagai bidan
- b. 1 mahasiswa sebagai pasien (ibu hamil)
- c. 1 mahasiswa sebagai anggota keluarga
- d. 1–2 mahasiswa sebagai observer

4. Langkah Kegiatan:

- a. Mahasiswa membaca skenario
- b. Melakukan simulasi konseling (10–15 menit)
- c. Observer menilai menggunakan checklist
- d. Diskusi dan umpan balik

5. Aspek yang Dinilai:

No	Komponen	Indikator Penilaian
1	Komunikasi terapeutik	Sopan, empati, menggunakan bahasa sederhana
2	Pengkajian	Menggali pola makan dan kepatuhan TTD
3	Edukasi gizi	Menjelaskan makanan sumber zat besi dan protein
4	Konseling TTD	Menjelaskan manfaat dan cara minum yang benar
5	Keterlibatan keluarga	Melibatkan keluarga dalam solusi
6	Rencana tindak lanjut	Memberikan saran kontrol dan pemantauan

6. Kriteria Penilaian:

- Sangat Baik: Semua aspek dilakukan dengan tepat, sistematis, dan komunikatif
- Baik: Sebagian besar aspek benar, ada kekurangan kecil
- Cukup: Beberapa aspek belum tepat
- Kurang: Banyak kesalahan dalam komunikasi dan tindakan

7. Output yang Diharapkan (OBE):

Mahasiswa mampu:

- Menunjukkan keterampilan komunikasi efektif
- Melakukan konseling gizi berbasis masalah
- Mengedukasi ibu dan keluarga secara tepat
- Mengambil keputusan sederhana di komunitas

J. Soal OSCE Kebidanan

No	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Pelayanan Gizi Ibu Hamil: Skrining Anemia dan KEK di Komunitas
3	Kasus	Ibu hamil dengan anemia dan risiko KEK di Posyandu
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam: 1. Melakukan skrining anemia dan KEK 2. Menginterpretasi hasil pemeriksaan 3. Menentukan diagnosis/masalah kebidanan 4. Melakukan edukasi dan intervensi awal 5. Menentukan rencana tindak lanjut
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	Seorang ibu hamil usia 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke Posyandu dengan keluhan mudah lelah, sering pusing, dan kurang nafsu makan. Hasil anamnesis: ibu jarang mengonsumsi tablet tambah darah karena merasa mual, pola makan didominasi karbohidrat, jarang konsumsi protein hewani. Hasil pemeriksaan TD 100/70 mmHg, Nadi 96 x/menit, Konjungtiva pucat, LILA 22 cm, Hb 9,5 g/dL TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus 2. Lakukan pemeriksaan fisik/skrining gizi yang relevan 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan 4. Lakukan tindakan awal yang tepat 5. Berikan KIE kepada ibu dan keluarga 6. Tentukan rencana tindak lanjut/rujukan
7	Instruksi penguji	Instruksi Khusus: Jika peserta: 1. Melakukan anamnesis → PS menjawab sesuai dialog 2. Meminta data → berikan: Hb 9,5 g/dL, LILA 22 cm 3. Menyimpulkan → arahkan ke anemia + KEK
8	Kebutuhan dan instruksi PS	1. Tampak lemah, sedikit pucat 2. Menjawab dengan pelan 3. Mengeluh mual saat minum TTD 4. Kooperatif saat diberi edukasi

No	Komponen	Isi
9	Dialog PS	Peserta: Apa keluhan ibu? PS: Saya sering pusing dan lemas Peserta: Apakah minum tablet tambah darah? PS: Tidak rutin, Bu, mual Peserta: Bagaimana makan sehari-hari? PS: Lebih sering nasi dan tempe saja
10	Kebutuhan manikin	Manekin: pita LILA, Hb strip
11	Kebutuhan laboran	Menyiapkan alat
12	Kebutuhan alat	Tensimeter, LILA, form KIA
13	Penulis	Dian Rahmawati
14	Referensi	- World Health Organization. (2020). <i>WHO guideline on use of ferritin concentrations to assess iron status</i>. https://www.who.int/publications/i/item/9789240000124 - World Health Organization. (2021). <i>Anaemia in women and children</i>. https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/anaemia

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat keluhan (lemas, pusing)		
3. Kepatuhan TTD		
4. Pola makan		
5. Riwayat kehamilan		
6. Riwayat penyakit		
7. Aktivitas harian		
8. Dukungan keluarga		

Skoring:

- 3= 8 langkah benar
- 2= 5–7 benar
- 1= 1–4 benar
- 0= tidak dilakukan

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan (komunikasi, consent, hand hygiene)		
2. Pemeriksaan:		
3. Tanda vital		
4. Konjungtiva		
5. LILA		
6. Hb		
7. Interpretasi: anemia + KEK		
8. Tindakan:		
9. Edukasi TTD		
10. Edukasi gizi		
11. Libatkan keluarga		
12. Rencana kontrol		

Skoring:

- 3= 15–19 langkah benar
- 2= 10–14
- 1= 1–9
- 0= tidak dilakukan

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Salam		
2. Menjelaskan kondisi (anemia + KEK)		
3. Edukasi TTD		
4. Edukasi gizi		
5. Libatkan keluarga		
6. Tanya jawab		

Skoring:

- 3= 6 benar
- 2= 4–5
- 1= 1–3
- 0= tidak

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sistematis		
2. Empati		
3. Komunikatif		
4. Tenang		
5. Percaya diri		

Skoring:

- 3 = 5 benar
- 2 = 4
- 1 = 1–3
- 0 = tidak

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3 (*dicatat di rubrik penilaian*)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{-----}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....
Penguji :

K. Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Skrining Anemia dan KEK pada Ibu Hamil di Komunitas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Skrining Anemia dan KEK
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, kemudian memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang dinilai meliputi komunikasi, informed consent, persiapan, keterampilan teknis, keselamatan pasien, dan profesionalisme.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan skrining anemia dan KEK pada ibu hamil di Posyandu, termasuk pengukuran LILA, pemeriksaan Hb sederhana, serta edukasi yang diberikan kepada ibu.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan skrining gizi secara tepat,	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pengetahuan tentang anemia dan KEK, tetapi dari

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Skrining Anemia dan KEK
	aman, dan sistematis, serta mampu menginterpretasi hasil dan memberikan intervensi awal berbasis komunitas.	kemampuannya melakukan pemeriksaan, mengidentifikasi risiko, serta memberikan edukasi gizi dan rencana tindak lanjut.
Kasus klinik	Kasus diambil dari situasi nyata di komunitas sesuai capaian pembelajaran, meliputi skrining anemia, pengukuran LILA, serta identifikasi risiko KEK.	Seorang ibu hamil usia 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke Posyandu dengan keluhan lemas. Hasil pemeriksaan: Hb 9,5 g/dL, LILA 22 cm, ibu tidak rutin minum tablet tambah darah, dan pola makan kurang protein.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan prosedur nyata, bukan hanya diskusi. Keterampilan yang diamati meliputi komunikasi, pemeriksaan, interpretasi, dan edukasi.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, melakukan pengukuran LILA, memeriksa Hb, menilai konjungtiva, menginterpretasi hasil (anemia + KEK), serta memberikan edukasi terkait konsumsi TTD dan pola makan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi indikasi tindakan, persetujuan, persiapan, teknik pemeriksaan, komunikasi, keselamatan pasien, dan rencana tindak lanjut.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan hasil Hb rendah dan LILA < 23,5 cm sebagai anemia dan KEK, serta menentukan intervensi yang tepat di tingkat komunitas.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi adalah performa nyata mahasiswa dalam melakukan tindakan klinik secara aman dan sistematis.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa melakukan skrining dengan benar, menggunakan alat dengan tepat, memberikan edukasi yang sesuai, serta melibatkan keluarga dalam intervensi.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, meliputi kelebihan dan area perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, tetapi perlu meningkatkan ketelitian dalam interpretasi hasil atau memperjelas edukasi tentang cara konsumsi tablet tambah darah.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Skrining Anemia dan KEK
Keputusan penilaian	Hasil DOPS dikategorikan menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial berdasarkan performa mahasiswa.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan skrining dan edukasi dengan tepat. Perlu supervisi jika masih membutuhkan arahan. Remedial jika tidak mampu mengidentifikasi anemia/KEK atau salah tindakan.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik pencapaian kompetensi pada level <i>does</i> , karena mahasiswa dinilai saat melakukan tindakan nyata.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori anemia dan KEK, tetapi mampu melakukan skrining dan edukasi secara langsung di komunitas secara profesional dan aman.

L. Portofolio

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 1.1

Portofolio pada Pencegahan Anemia, KEK, dan Stunting Berbasis Keluarga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anemia, KEK, dan Stunting
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam konteks nyata pelayanan kebidanan komunitas.	Portofolio memuat bukti kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi ibu hamil anemia, WUS dengan KEK, dan balita berisiko stunting melalui data KIA, serta melakukan intervensi berbasis keluarga.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi,	Mahasiswa menunjukkan perkembangan kemampuan dalam menganalisis data e-

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anemia, KEK, dan Stunting
	refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa.	PPGBM, menentukan prioritas masalah, dan merencanakan intervensi gizi keluarga.
Mini case dan OSCE	Mini case dan OSCE menjadi bagian penting portofolio sebagai bukti keterampilan analisis kasus dan keterampilan klinik terstruktur.	Mini case: analisis ibu hamil dengan Hb 9 g/dL dan LILA <23,5 cm. OSCE: konseling pemberian tablet tambah darah dan edukasi gizi keluarga.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus yang pernah ditangani mahasiswa, meliputi data penting, masalah, tindakan, dan hasil.	Ibu hamil trimester II dengan anemia dan KEK, pola makan kurang, intervensi edukasi gizi dan TTD, serta tindak lanjut kunjungan rumah.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko dan dampak masalah gizi terhadap ibu dan anak.	Mahasiswa merefleksikan risiko anemia terhadap perdarahan persalinan dan risiko KEK terhadap BBLR dan stunting.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari pembimbing terkait performa mahasiswa.	Mahasiswa sudah baik dalam analisis data KIA, namun perlu meningkatkan keterampilan komunikasi saat konseling keluarga.
Karakteristik penilaian	Penilaian bersifat berkelanjutan dan menilai konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa kegiatan: posyandu, kunjungan rumah, dan praktik klinik.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mempertahankan performa pada berbagai situasi.	Mahasiswa konsisten mampu mengidentifikasi risiko anemia, KEK, dan stunting serta melakukan intervensi sederhana.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mencapai capaian pembelajaran melalui praktik nyata.	Mahasiswa mampu menerapkan konsep gizi ibu dan anak dalam pelayanan komunitas secara konsisten.

Tabel 1.2
Case Report pada Pencegahan Anemia, KEK, dan Stunting Berbasis Keluarga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anemia, KEK, dan Stunting
Hakikat case report	Laporan sistematis tentang satu kasus nyata yang ditangani mahasiswa di komunitas atau fasilitas kesehatan.	Mahasiswa menyusun laporan kasus ibu hamil dengan anemia dan KEK yang berisiko melahirkan bayi stunting.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan integrasi data, analisis masalah, intervensi, dan evaluasi.	Mahasiswa mengintegrasikan data Hb, LILA, pola makan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Isi laporan	Identitas, keluhan, data subjektif-objektif, analisis, diagnosis, intervensi, evaluasi.	Data: Hb 9 g/dL, LILA 22 cm, asupan kurang → diagnosis anemia + KEK → intervensi TTD, edukasi gizi, pemantauan.
Fokus penilaian	Ketepatan analisis masalah, logika klinik, dan intervensi berbasis bukti.	Mahasiswa dinilai mampu menghubungkan anemia ibu dengan risiko stunting pada bayi.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan kemampuan dokumentasi.	Mahasiswa belajar pentingnya deteksi dini dan intervensi berbasis keluarga.
Makna dalam OBE	Bukti kemampuan menerapkan teori dalam kasus nyata secara sistematis.	Mahasiswa mampu menyusun laporan yang mencerminkan asuhan kebidanan komunitas.

Tabel 1.3
Refleksi Patient Safety pada Pencegahan Anemia, KEK, dan Stunting

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anemia, KEK, dan Stunting
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi tentang risiko keselamatan ibu dan anak akibat masalah gizi serta upaya pencegahannya.	Mahasiswa menyadari bahwa anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko perdarahan dan kematian ibu.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa KEK dapat menyebabkan BBLR dan meningkatkan risiko stunting.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.	Risiko: anemia, KEK, stunting akibat kurangnya asupan dan edukasi.
Risiko yang diidentifikasi	Kemampuan mengenali kondisi berisiko.	Keterlambatan deteksi anemia, kepatuhan rendah konsumsi TTD, pola makan tidak adekuat.
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko.	Edukasi gizi, pemantauan konsumsi TTD, pemanfaatan pangan lokal, kunjungan rumah.

Pembelajaran mahasiswa	Refleksi pengalaman untuk perbaikan praktik.	Mahasiswa menyadari pentingnya pendekatan keluarga dan komunikasi efektif dalam perubahan perilaku.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis.	Mahasiswa mampu mengevaluasi praktik dan meningkatkan kualitas pelayanan gizi ibu dan anak.

M. Latihan

- Seorang bidan menemukan bahwa di wilayah kerjanya terdapat peningkatan kasus anemia pada ibu hamil. Data menunjukkan sebagian besar ibu tidak mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) secara rutin. Tindakan prioritas berbasis OBE yang paling tepat adalah...
 - Memberikan TTD tanpa edukasi
 - Melakukan rujukan semua ibu hamil
 - Menyusun intervensi edukasi berbasis keluarga tentang konsumsi TTD
 - Menunggu laporan dari Puskesmas
 - Menghentikan program TTD
- Seorang mahasiswa kebidanan diminta menganalisis data Posyandu yang menunjukkan peningkatan balita dengan status gizi kurang. Langkah awal yang tepat dalam pendekatan berbasis data adalah...
 - Langsung memberikan PMT
 - Mengidentifikasi penyebab melalui analisis data keluarga
 - Menyalahkan kader Posyandu
 - Menghentikan kegiatan Posyandu
 - Melaporkan tanpa analisis
- Seorang ibu hamil dengan LILA 22 cm datang ke Posyandu. Berdasarkan standar, kondisi ini menunjukkan...
 - Normal
 - Obesitas
 - KEK
 - Anemia
 - Dehidrasi

4. Dalam skrining anemia di komunitas, hasil Hb ibu hamil adalah 9 g/dL. Interpretasi yang tepat adalah...
- A. Normal
 - B. Anemia ringan
 - C. Anemia sedang
 - D. Anemia berat
 - E. Tidak dapat dinilai
5. Seorang bidan melakukan pemantauan pertumbuhan balita menggunakan grafik WHO. Ditemukan Z-score TB/U < -2 SD. Interpretasi yang tepat adalah...
- A. Normal
 - B. Gizi kurang
 - C. Stunting
 - D. Wasting
 - E. Overweight
6. Dalam pendekatan pelayanan kebidanan komunitas, faktor yang termasuk determinan sosial gizi adalah...
- A. Golongan darah ibu
 - B. Status ekonomi keluarga
 - C. Jenis kelamin bayi
 - D. Usia kehamilan
 - E. Berat badan lahir
7. Seorang bidan ingin menentukan prioritas masalah gizi di wilayahnya. Data menunjukkan prevalensi stunting paling tinggi dibandingkan anemia dan KEK. Keputusan yang tepat adalah...
- A. Mengabaikan data
 - B. Fokus pada stunting sebagai prioritas utama
 - C. Menangani semua masalah tanpa prioritas
 - D. Menunggu instruksi pusat
 - E. Hanya fokus pada anemia

8. Dalam penyusunan intervensi gizi berbasis keluarga, prinsip utama yang harus diperhatikan adalah...
- A. Fokus pada tenaga kesehatan saja
 - B. Mengabaikan peran keluarga
 - C. Melibatkan keluarga dalam perubahan perilaku
 - D. Memberikan obat tanpa edukasi
 - E. Mengutamakan tindakan kuratif saja
9. Dalam penyusunan intervensi gizi berbasis keluarga, prinsip utama yang harus diperhatikan adalah...
- A. Fokus pada tenaga kesehatan saja
 - B. Mengabaikan peran keluarga
 - C. Melibatkan keluarga dalam perubahan perilaku
 - D. Memberikan obat tanpa edukasi
 - E. Mengutamakan tindakan kuratif saja
10. Dalam monitoring program gizi, indikator outcome yang tepat adalah...
- A. Jumlah kader
 - B. Jumlah TTD tersedia
 - C. Cakupan kunjungan ANC
 - D. Penurunan prevalensi stunting
 - E. Jumlah laporan masuk

Kunci Jawaban

- 1. C
- 2. B
- 3. C
- 4. C
- 5. C
- 6. B
- 7. B
- 8. C
- 9. B
- 10. D

N. Rangkuman Materi

Pelayanan kebidanan komunitas berbasis gizi memerlukan pemahaman yang komprehensif mulai dari konsep dasar hingga implementasi program. Dimulai dari determinan sosial gizi dan pentingnya periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mahasiswa diarahkan untuk memahami bahwa status gizi ibu dan anak dipengaruhi oleh faktor multidimensional, termasuk keluarga dan lingkungan. Selanjutnya, kemampuan dalam melakukan skrining risiko anemia, KEK, dan stunting melalui pengukuran sederhana seperti Hb, LILA, serta antropometri menjadi keterampilan utama. Pemanfaatan data dari Posyandu, PWS-KIA, dan e-PPGBM memungkinkan analisis masalah kesehatan secara berbasis wilayah, sehingga bidan dapat menetapkan prioritas masalah dan menyusun diagnosis komunitas secara tepat.

Selain itu, materi ini juga menekankan pentingnya penyusunan intervensi gizi berbasis keluarga yang mencakup pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Edukasi gizi, pemberian tablet tambah darah, serta perbaikan pola makan keluarga menjadi strategi utama dalam pencegahan anemia, KEK, dan stunting. Keberhasilan intervensi sangat ditentukan oleh strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Monitoring dan evaluasi program dilakukan melalui indikator yang terukur, sistem pencatatan yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor seperti kader, PKK, Puskesmas, dan pemerintah desa. Dengan pendekatan ini, bidan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang holistik, berbasis bukti, dan berkelanjutan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di komunitas.

O. Glosarium

- ASI : Air Susu Ibu
- BBLR : Bayi Berat Lahir Rendah
- e-PPGBM : Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat
- HPK : Hari Pertama Kehidupan
- IMD : Inisiasi Menyusu Dini
- KIA : Kesehatan Ibu dan Anak
- KIE : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
- KMS : Kartu Menuju Sehat
- KEK : Kekurangan Energi Kronis
- LILA : Lingkar Lengan Atas
- MP-ASI : Makanan Pendamping Air Susu Ibu
- Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu
- PUS : Pasangan Usia Subur
- PWS-KIA : Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak

TTD : Tablet Tambah Darah

WUS : Wanita Usia Subur

P. Referensi

- Aldakhil, L. O., Alobaid, S., Almogbel, A. T., & Alfouzan, S. M. (2025). Anemia in Pregnancy: Incidence , Risk Factors , and Outcomes. *Cureus*, 17(10). <https://doi.org/10.7759/cureus.93807>
- Anjani, A. D., Aulia, D. L. N., & Diana, S. (2024). Pentingnya Kebutuhan Nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.37287/jppp.v6i4.2671>
- Azzam, A., Khaled, H., Alrefaey, A. K., Basil, A., Ibrahim, S., & Elsayed, M. S. (2025). Anemia in pregnancy: a systematic review and meta-analysis of prevalence , determinants , and health impacts in Egypt. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 29. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12884-024-07111-9> (2025)
- Beal, T. (2021). Global dietary patterns. *Nature Food*. <https://doi.org/10.1038/s43016-021-00273-5>
- Bhutta, Z. A. (2020). Evidence-based interventions for maternal and child nutrition. *The Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31646-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31646-4)
- Byrum, J. R., Waltari, E., Janson, O., Guo, S., Folkesson, J., Chhun, B. B., Vinden, J., Ivanov, I. E., Forst, M. L., Li, H., Larson, A. G., Blackmon, L., Liu, Z., Wu, W., Ah Yong, V., Tato, C. M., Mccutcheon, K. M., Hoh, R., Kelly, J. D., ... Pak, J. E. (2023). MultiSero : An Open-Source Multiplex-ELISA Platform for Measuring Antibody Responses to Infection. *Pathogens*, 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/pathogens12050671>
- Friis, R. H., & Sellers, T. A. (2021). *Epidemiology for public health practice*. Jones & Bartlett Learning.
- Gordis, L. (2020). *Epidemiology*. Elsevier.
- Hasneli, Y., Adipa, M. E., Ramadlani, L. P., Veronika, J., Hasanah, N. S., Annisya, N., Nurwahyuni, Nuryanti, Putri, R. A., & Khoiriyah, R. (2023). Edukasi Pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) Sebagai Langkah Pencegahan Stunting di Kelurahan Perawang Kabupaten Siak. *Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56744/irchum.v2i2.40>
- Indrastuty, D., & Pujiyanto. (2014). Determinan Sosial Ekonomi Rumah Tangga dari Balita Stunting di Indonesia : Analisis Data Indonesia Family Life Survey (IFLS). *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/DOI:10.7454/eki.v3i2.3004>
- Kemenkes, R. (2020). *Pedoman pemantauan pertumbuhan*.

<https://repository.kemkes.go.id/book/182>

Kemenkes, R. (2021). *Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)*.

Kemenkes, R. (2022). *Pedoman e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)*.

Khezri, R., Rezaei, F., Jahanfar, S., & Ebrahimi, K. (2025). Association between maternal anemia during pregnancy with low birth weight their infants. *Scientific Reports (Nature Publishing Group)*, 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41598-025-91316-1>

Likhar, A., & Patil, M. S. (2022). Importance of Maternal Nutrition in the First 1,000 Days of Life and Its Effects on Child Development: A Narrative Review. *Cureus*, 14(10). <https://doi.org/10.7759/cureus.30083>

Luca, A. C., Roșu, S. T., Diaconescu, C., Mîndru, D. E., Gavrilovici, C., Vizireanu, A., Țarcă, V., Roșu, E. V., & Țarcă, E. (2026). The First 1000 Days: Maternal Nutrient Intake—A Window of Opportunity for Pulmonary Hypertension—A Narrative Review. *Nutrients*, 18(3), 424. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/nu18030424>

Muhammad, R., Mahawati, E., & Rimawati, E. (2025). LITERATURE REVIEW FAKTOR-FAKTOR MULTISEKTORAL YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA STUNTING PADA BALITA DI. *JURNAL NERS*, 9(4), 7175–7183. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jn.v9i4.50906>

Organization, W. H. (2024). *Malnutrition*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>

Organization, W. H. (2025). *Nutrition Landscape Information System (NLIS) country profile*. <https://www.who.int/data/nutrition/nlis/country-profile>

Percepatan Penurunan Stunting (2021).

Rahayu, S., Ronny, A., Dewi, A., Nadhira, A., & Arinda, P. (2024). Model development for anemia prediction in pregnancy. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 28(April), 101654. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2024.101654>

Rahmawati, D., Agustin, L., Sari, A. N., Nur, T., Indonesia, U. S., & Keperawatan, F. (2024). THE RELATIONSHIP BETWEEN FEEDING PATTERNS AND THE INCIDENCE. *Jurnal Ilmu Kesehatan Akper Dharma Husada Kediri*, 13(1), 81–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.32831/jik.v13i1.743>

RI, K. (2020). *Pedoman pelayanan gizi*.

RI, K. K. (2020). *Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)*.

Ruel, M. T. (2021). Nutrition-sensitive interventions and programmes. *The Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01240-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01240-3)

Sarilisnawati, Hasyim, H., & Fajar, N. A. (2022). Analisis Hubungan Karakteristik Ibu,

- Pengetahuan, dan Sosial Budaya dengan Kejadian Stunting. *Jurnal Kesehatan*, 13(1), 151–160.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35730/jk.v13i0.824>
- Shrestha, M. L., Perry, K. E., & Weissman, A. (2022). Malnutrition matters : Association of stunting and underweight with early childhood development indicators in Nepal. *Maternal & Child Nutrition*, 18, 1–9.
<https://doi.org/10.1111/mcn.13321>
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public health nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Taher, R., Priliana, W. K., Alow, G. B. H., Dormina, S, E. P., S, N. S., Manik, R., Hermanses, S. S., Sarimin, D. S., Subriah, Sambo, M., Sari, R. S., Sihombing, N. H., Wati, I., & Sharfina, D. (2025). *Kesehatan Ibu dan Anak*. PT Media Pustaka Indo. <https://media.neliti.com/media/publications/618504-kesehatan-ibu-dan-anak-a943db0a.pdf>
- Ubom, A. E., Begum, F., Ramasauskaite, D., & Nieto-, A. J. (2025). FIGO good practice recommendations on anemia in pregnancy , to reduce the incidence and impact of postpartum hemorrhage (PPH). *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 171(June), 993–1007.
<https://doi.org/10.1002/ijgo.70529>
- Victora, C. G., Christian, P., Vdaletti, L. P., Gatica-Domínguez, G., Menon, P., & Black, R. E. (2022). Revisiting maternal and child undernutrition in low-income and middle-income countries : variable progress towards an unfinished agenda. *The Lancet*, 397(10282), 1388–1399.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00394-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00394-9).Revisiting
- WHO. (2020a). *Basic epidemiology*. World Health Organization.
- WHO. (2020b). *Guideline on iron supplementation*. <https://www.who.int>
- WHO. (2025a). *Child growth standards*. <https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards>
- WHO. (2025b). *WHO Guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age*. WHO.
- WHO, & UNICEF. (2019). *Recommendations for data collection, analysis and reporting on anthropometric indicators in children under 5 years old*.

BAB 2 :

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI KOMUNITAS: EDUKASI, PENCEGAHAN RISIKO, DAN RUJUKAN

Capaian Pembelajaran Lulusan

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang Berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, kebijakan, prinsip, dan evidence-based practice dalam pelayanan kebidanan komunitas, khususnya kesehatan reproduksi remaja, edukasi, pencegahan risiko, dan sistem rujukan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian kebutuhan dan permasalahan kesehatan reproduksi remaja pada individu, keluarga, dan komunitas menggunakan data, faktor risiko, dan pendekatan kebidanan komunitas.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-3	Mampu merencanakan dan memberikan asuhan kebidanan komunitas pada remaja melalui upaya promotif, preventif, edukatif, konseling, dan tindak lanjut sesuai kebutuhan klien.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-6
CPL-4	Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis komunitas melalui kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan sistem rujukan yang berkesinambungan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu melakukan komunikasi efektif, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), konseling, promosi kesehatan, serta pemberdayaan remaja, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan yang ramah remaja dan sensitif budaya.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6
CPL-6	Menunjukkan profesionalisme, etika, keselamatan klien, penghormatan terhadap hak dan privasi remaja, serta	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang Berkontribusi
	mampu melakukan evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan reproduksi remaja di komunitas.	

CPMK

Kode	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menunjukkan sikap profesional, etika, komunikasi efektif, dan pelayanan yang ramah remaja dalam pemberian edukasi dan konseling kesehatan reproduksi di komunitas.
CPMK-2	Menjelaskan konsep kesehatan reproduksi remaja, perubahan fisik, psikologis, sosial, serta permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja.
CPMK-3	Menganalisis faktor risiko, permasalahan kesehatan reproduksi, serta kebutuhan edukasi pada remaja di komunitas berdasarkan hasil pengkajian.
CPMK-4	Melaksanakan edukasi, promosi kesehatan, dan konseling kesehatan reproduksi remaja menggunakan metode KIE yang sesuai dengan karakteristik remaja.
CPMK-5	Melakukan pengkajian kesehatan reproduksi remaja, menentukan kebutuhan tindak lanjut, kolaborasi, dan rujukan sesuai standar pelayanan kebidanan.
CPMK-6	Melaksanakan asuhan kebidanan komunitas pada remaja secara komprehensif, termasuk dokumentasi pelayanan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai kewenangan bidan.

Pendahuluan

Kesehatan reproduksi remaja merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Remaja berada pada masa transisi dari anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial, sehingga membutuhkan informasi dan dukungan yang tepat terkait kesehatan reproduksi. Kurangnya pengetahuan dan akses terhadap informasi yang benar dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan reproduksi, seperti kehamilan tidak direncanakan, infeksi menular seksual, serta perilaku berisiko lainnya.

Dalam konteks kebidanan komunitas, bidan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, konseling, serta promosi kesehatan reproduksi kepada

remaja. Edukasi kesehatan reproduksi bertujuan meningkatkan pengetahuan remaja mengenai perubahan tubuh, menjaga kesehatan reproduksi, serta mendorong perilaku hidup sehat. Kegiatan edukasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan di komunitas, seperti penyuluhan di sekolah, kegiatan posyandu remaja, atau program pelayanan kesehatan ramah remaja.

Upaya pencegahan risiko kesehatan reproduksi pada remaja dilakukan melalui strategi promosi kesehatan, komunikasi yang efektif, serta pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan kondisi sosial remaja. Pendekatan ini juga melibatkan keluarga, kader kesehatan, serta masyarakat sebagai bagian dari dukungan lingkungan yang positif bagi perkembangan remaja.

Selain edukasi dan pencegahan, tenaga kesehatan juga perlu mampu mengidentifikasi masalah kesehatan reproduksi pada remaja yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Jika ditemukan kondisi yang membutuhkan pemeriksaan atau penanganan lanjutan, bidan perlu melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai. Sistem rujukan yang baik akan membantu remaja mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pelayanan kesehatan reproduksi remaja di komunitas memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi, pencegahan risiko, komunikasi efektif, serta mekanisme rujukan yang tepat, sehingga remaja dapat mencapai kondisi kesehatan reproduksi yang optimal.

Uraian Materi

A. Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Definisi Remaja

Remaja merupakan fase perkembangan yang berada pada masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Periode ini ditandai dengan terjadinya perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Perubahan tersebut berkaitan dengan proses pubertas yang menyebabkan kematangan organ reproduksi serta perkembangan kemampuan kognitif dan emosional individu (Santrock, 2019).

Menurut World Health Organization (WHO), remaja adalah individu yang berada pada rentang usia 10–19 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan hormonal yang memicu perkembangan karakteristik seksual sekunder serta pematangan fungsi sistem reproduksi (WHO, 2022). Masa remaja juga merupakan periode penting dalam pembentukan perilaku kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi di masa dewasa.

Di Indonesia, remaja merupakan kelompok usia yang memiliki kerentanan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi, seperti kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko, serta pengaruh lingkungan sosial dan media digital yang semakin luas (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

2. Definisi Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan kondisi kesejahteraan secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Konsep kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan penyakit, tetapi juga mencakup kemampuan individu untuk memiliki kehidupan reproduksi yang aman dan bertanggung jawab (WHO, 2020).

Dalam konteks remaja, kesehatan reproduksi mencakup pemahaman mengenai perubahan tubuh selama masa pubertas, pengetahuan mengenai fungsi organ reproduksi, serta kemampuan untuk menjaga kesehatan reproduksi melalui perilaku hidup sehat. Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah kesehatan seperti kehamilan tidak direncanakan dan infeksi menular seksual (Chandra-Mouli et al., 2021).

Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja perlu dilakukan melalui pendekatan edukasi, konseling, serta pelayanan

kesehatan yang ramah remaja di komunitas. Peran tenaga kesehatan, termasuk bidan, sangat penting dalam memberikan informasi yang akurat, membangun komunikasi yang efektif dengan remaja, serta membantu remaja mengambil keputusan yang sehat terkait kesehatan reproduksinya.

B. Perubahan pada Masa Remaja

Masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai dengan berbagai perubahan yang terjadi secara cepat dan kompleks. Perubahan tersebut meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan ini berkaitan erat dengan proses pubertas serta perkembangan kemampuan kognitif dan emosional individu. Pemahaman yang baik mengenai perubahan pada masa remaja sangat penting untuk membantu remaja beradaptasi secara sehat serta mencegah terjadinya masalah kesehatan reproduksi.

1. Perubahan Fisik

Perubahan fisik pada masa remaja berkaitan dengan proses pubertas, yaitu proses pematangan organ reproduksi yang memungkinkan seseorang mencapai kemampuan reproduksi. Pubertas dipicu oleh perubahan hormonal yang menyebabkan pertumbuhan pesat serta munculnya karakteristik seksual sekunder.

Pada remaja perempuan, perubahan fisik yang umum terjadi meliputi:

- a. perkembangan payudara
- b. pertumbuhan rambut pada daerah ketiak dan pubis
- c. pelebaran panggul
- d. mulai terjadinya menstruasi (menarche)

Menstruasi pertama atau menarche merupakan salah satu tanda penting bahwa sistem reproduksi perempuan mulai berfungsi. Namun pada awal masa remaja, siklus menstruasi sering kali belum teratur karena sistem hormonal masih dalam proses penyesuaian (WHO, 2022).

Selain perubahan pada sistem reproduksi, remaja juga mengalami pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang cepat, peningkatan massa tulang, serta perubahan komposisi tubuh. Perubahan fisik ini dapat mempengaruhi persepsi diri remaja terhadap tubuhnya sehingga memerlukan pemahaman dan dukungan dari lingkungan sekitar.

2. Perubahan Psikologis

Perubahan psikologis pada masa remaja berkaitan dengan perkembangan emosional dan kognitif. Remaja mulai mengembangkan

kemampuan berpikir abstrak, memahami konsep yang lebih kompleks, serta mulai mencari identitas diri. Pada tahap ini, remaja juga cenderung mengalami perubahan suasana hati yang cepat akibat pengaruh perubahan hormonal dan tekanan sosial.

Remaja sering menunjukkan keinginan untuk memperoleh kemandirian dari orang tua, namun pada saat yang sama masih membutuhkan dukungan dan bimbingan dari orang dewasa. Perasaan ingin tahu yang tinggi serta dorongan untuk mencoba hal-hal baru dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku remaja, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi.

Perubahan psikologis ini juga dapat mempengaruhi cara remaja mengambil keputusan, sehingga edukasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi sangat penting agar remaja dapat membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab.

3. Perubahan Sosial

Perubahan sosial pada masa remaja berkaitan dengan perkembangan hubungan interpersonal serta peran individu dalam lingkungan sosial. Pada periode ini, pengaruh teman sebaya menjadi sangat kuat dan sering kali lebih dominan dibandingkan pengaruh keluarga. Remaja mulai membentuk hubungan sosial yang lebih luas, termasuk hubungan dengan lawan jenis.

Lingkungan sosial, termasuk keluarga, sekolah, serta media sosial, memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan dan sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi. Informasi yang diperoleh dari media sosial sering kali tidak selalu akurat, sehingga remaja memerlukan sumber informasi yang benar dari tenaga kesehatan dan program edukasi di komunitas.

Dalam konteks kebidanan komunitas, pemahaman mengenai perubahan fisik, psikologis, dan sosial pada remaja sangat penting untuk merancang strategi edukasi kesehatan reproduksi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan remaja.

C. Permasalahan Kesehatan Reproduksi Remaja

Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi. Kerentanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, pengaruh lingkungan sosial, akses terhadap informasi yang tidak tepat, serta keterbatasan layanan kesehatan yang ramah remaja. Permasalahan kesehatan

reproduksi pada remaja tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis, sosial, serta masa depan remaja.

Menurut World Health Organization (WHO), masalah kesehatan reproduksi pada remaja menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat global yang memerlukan perhatian khusus karena dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas pada kelompok usia muda. Oleh karena itu, upaya promotif dan preventif melalui edukasi serta pelayanan kesehatan yang ramah remaja sangat diperlukan untuk mencegah berbagai masalah kesehatan reproduksi pada kelompok usia ini (WHO, 2022).

1. Kehamilan pada Remaja

Kehamilan pada remaja merupakan salah satu permasalahan kesehatan reproduksi yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kehamilan pada usia remaja dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko, serta rendahnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi.

Kehamilan pada usia remaja memiliki berbagai risiko kesehatan baik bagi ibu maupun bayi. Pada remaja perempuan, kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti anemia, preeklamsia, persalinan prematur, serta bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain itu, kehamilan pada usia remaja juga dapat berdampak pada aspek sosial, seperti putus sekolah, keterbatasan kesempatan kerja, serta masalah psikologis (Kemenkes RI, 2021).

Oleh karena itu, upaya pencegahan kehamilan pada remaja perlu dilakukan melalui pendidikan kesehatan reproduksi, peningkatan akses informasi yang benar, serta dukungan keluarga dan masyarakat.

2. Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual dan dapat menyerang sistem reproduksi. Remaja termasuk kelompok yang rentan terhadap infeksi menular seksual karena kurangnya pengetahuan mengenai cara pencegahan serta kecenderungan untuk melakukan perilaku berisiko.

Beberapa jenis infeksi menular seksual yang sering ditemukan antara lain gonore, sifilis, klamidia, serta infeksi HIV. Infeksi ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik, seperti

infertilitas, penyakit radang panggul, serta peningkatan risiko penularan HIV.

Upaya pencegahan IMS pada remaja dapat dilakukan melalui edukasi mengenai kesehatan reproduksi, peningkatan kesadaran tentang perilaku seksual yang aman, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang ramah remaja untuk deteksi dan pengobatan dini.

3. Perilaku Seksual Berisiko

Perilaku seksual berisiko pada remaja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rasa ingin tahu yang tinggi, tekanan dari teman sebaya, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh media dan internet. Kurangnya informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi dapat menyebabkan remaja mengambil keputusan yang tidak tepat terkait perilaku seksual.

Perilaku seksual berisiko dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan tidak direncanakan serta infeksi menular seksual. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif sangat penting untuk membantu remaja memahami konsekuensi dari perilaku tersebut serta mendorong mereka untuk membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab.

4. Kurangnya Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi pada remaja adalah kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi. Banyak remaja memperoleh informasi dari sumber yang tidak terpercaya, seperti media sosial atau teman sebaya, sehingga informasi yang diperoleh sering kali tidak akurat.

Kurangnya pengetahuan ini dapat menyebabkan remaja memiliki persepsi yang salah mengenai fungsi organ reproduksi, menstruasi, serta cara menjaga kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan, guru, serta keluarga sangat penting dalam memberikan edukasi yang benar dan sesuai dengan kebutuhan remaja.

Dalam konteks kebidanan komunitas, bidan memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi, melakukan konseling kepada remaja, serta mengembangkan program edukasi kesehatan reproduksi di masyarakat.

D. Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Komunitas

Edukasi kesehatan reproduksi merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi. Edukasi yang diberikan secara tepat dapat membantu remaja memahami perubahan yang terjadi pada tubuhnya, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang sehat, serta mencegah berbagai risiko kesehatan reproduksi (UNFPA, 2020).

Dalam konteks kebidanan komunitas, edukasi kesehatan reproduksi dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan kesehatan di sekolah, kegiatan posyandu remaja, serta program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di fasilitas pelayanan kesehatan. Program tersebut bertujuan untuk menyediakan informasi kesehatan reproduksi yang akurat serta layanan kesehatan yang ramah remaja (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa edukasi kesehatan reproduksi yang diberikan secara terstruktur dapat meningkatkan pengetahuan serta sikap positif remaja terhadap kesehatan reproduksi. Edukasi yang melibatkan metode interaktif seperti diskusi kelompok dan konseling individu terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi (Widman et al., 2018).

1. Tujuan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Edukasi kesehatan reproduksi pada remaja memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- a. Meningkatkan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi.
- b. Membantu remaja memahami perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada masa pubertas.
- c. Mencegah terjadinya perilaku berisiko yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi.
- d. Mendorong remaja untuk menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi.
- e. Meningkatkan kesadaran remaja untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan apabila mengalami masalah kesehatan reproduksi.

Melalui edukasi yang tepat, remaja diharapkan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya.

2. Materi Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Materi edukasi kesehatan reproduksi yang diberikan kepada remaja perlu disesuaikan dengan tingkat usia, kebutuhan, serta kondisi sosial

budaya masyarakat. Secara umum, materi edukasi kesehatan reproduksi remaja dapat meliputi:

- a. perubahan fisik dan psikologis pada masa pubertas
- b. fungsi dan anatomi organ reproduksi
- c. menstruasi dan kebersihan organ reproduksi
- d. pencegahan infeksi menular seksual
- e. pencegahan perilaku seksual berisiko
- f. pentingnya menjaga kesehatan reproduksi

Materi edukasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami serta menggunakan metode yang menarik agar remaja lebih mudah menerima informasi yang diberikan.

3. Metode Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Penyampaian edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja dapat dilakukan dengan berbagai metode agar informasi yang diberikan lebih mudah dipahami dan diterima oleh remaja. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain:

a. Penyuluhan Kesehatan

Penyuluhan dilakukan secara langsung kepada kelompok remaja dengan menggunakan media edukasi seperti poster, leaflet, atau presentasi.

b. Diskusi kelompok

Metode diskusi memungkinkan remaja untuk bertanya dan berbagi pengalaman sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif.

c. Konseling individu

Konseling dilakukan untuk membantu remaja yang memiliki masalah kesehatan reproduksi secara lebih personal dan menjaga kerahasiaan informasi.

d. Media digital dan media sosial

Pemanfaatan media digital dapat menjadi sarana edukasi yang efektif karena remaja sangat akrab dengan teknologi dan media sosial.

Penggunaan metode yang tepat dapat meningkatkan efektivitas edukasi kesehatan reproduksi sehingga pesan kesehatan dapat diterima dengan baik oleh remaja.

4. Peran Bidan dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Bidan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja di komunitas. Dalam menjalankan peran tersebut, bidan dapat melakukan berbagai kegiatan seperti penyuluhan kesehatan,

konseling kesehatan reproduksi, serta kerja sama dengan sekolah dan masyarakat dalam memberikan informasi kesehatan yang benar kepada remaja.

Selain itu, bidan juga perlu menciptakan suasana pelayanan yang ramah remaja sehingga remaja merasa nyaman untuk berkonsultasi mengenai masalah kesehatan reproduksi yang mereka alami. Melalui edukasi yang berkelanjutan, diharapkan remaja memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjaga kesehatan reproduksi serta mampu menghindari berbagai perilaku yang dapat membahayakan kesehatan reproduksinya.

E. Pencegahan Risiko Kesehatan Reproduksi Remaja di Komunitas

Pencegahan risiko kesehatan reproduksi pada remaja merupakan upaya yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya berbagai masalah kesehatan reproduksi, seperti kehamilan tidak direncanakan, infeksi menular seksual, dan perilaku seksual berisiko. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi, penguatan keterampilan hidup sehat, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial (WHO, 2022).

Menurut World Health Organization (WHO), upaya pencegahan masalah kesehatan reproduksi remaja harus dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan hidup sehat, serta penyediaan pelayanan kesehatan yang ramah remaja. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu remaja memahami risiko yang mungkin terjadi serta mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang sehat terkait kesehatan reproduksinya (WHO, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai kesehatan reproduksi cenderung memiliki perilaku yang lebih sehat dalam menjaga kesehatan reproduksinya. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan reproduksi merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pencegahan risiko kesehatan reproduksi pada remaja (Bastable et al., 2020).

Dalam konteks kebidanan komunitas, bidan memiliki peran penting dalam melaksanakan berbagai kegiatan promotif dan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan reproduksi pada remaja.

1. Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi

Salah satu langkah utama dalam pencegahan risiko kesehatan reproduksi pada remaja adalah meningkatkan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan yang memadai dapat

membantu remaja memahami perubahan yang terjadi pada tubuhnya, mengenali risiko kesehatan reproduksi, serta mengetahui cara menjaga kesehatan reproduksi dengan baik.

Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi di komunitas, seperti penyuluhan kesehatan, diskusi kelompok remaja, serta kegiatan pendidikan kesehatan di sekolah. Materi yang diberikan harus disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman remaja agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

2. Penguatan Perilaku Hidup Sehat

Perilaku hidup sehat merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan reproduksi remaja. Remaja perlu didorong untuk menerapkan perilaku hidup sehat, seperti menjaga kebersihan organ reproduksi, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik secara teratur, serta menghindari perilaku berisiko yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi.

Selain itu, remaja juga perlu dibekali dengan keterampilan dalam mengambil keputusan yang sehat serta kemampuan untuk menolak tekanan dari lingkungan yang dapat mendorong mereka melakukan perilaku berisiko.

3. Peran Keluarga dalam Pencegahan Risiko

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesehatan reproduksi remaja. Orang tua merupakan sumber informasi pertama bagi remaja mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan mereka. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan remaja dapat membantu remaja memperoleh informasi yang benar serta merasa lebih nyaman untuk membicarakan masalah yang mereka hadapi.

Dukungan keluarga juga dapat membantu remaja dalam mengembangkan perilaku yang sehat serta menghindari berbagai perilaku berisiko yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi.

4. Peran Masyarakat dan Lingkungan

Selain keluarga, lingkungan masyarakat juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan reproduksi remaja. Lingkungan yang mendukung dapat membantu remaja memperoleh informasi kesehatan yang benar serta memberikan dukungan sosial yang positif bagi perkembangan remaja.

Kegiatan komunitas seperti posyandu remaja, program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), serta kegiatan kelompok remaja di masyarakat dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi.

Melalui kerja sama antara tenaga kesehatan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan risiko kesehatan reproduksi pada remaja dapat dilakukan secara optimal sehingga remaja dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.

F. Sistem Rujukan Kesehatan Reproduksi Remaja di Komunitas

Sistem rujukan merupakan mekanisme pelimpahan tanggung jawab pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan yang lebih lengkap. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, sistem rujukan diperlukan apabila ditemukan kondisi yang memerlukan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut, seperti gangguan menstruasi berat, infeksi menular seksual, atau kehamilan pada remaja (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sistem rujukan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal. Rujukan dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal sesuai dengan tingkat kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2021).

Bidan di komunitas memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini terhadap masalah kesehatan reproduksi remaja serta menentukan kebutuhan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Melalui sistem rujukan yang baik, remaja dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang tepat dan berkelanjutan.

Dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, bidan di komunitas memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini terhadap masalah kesehatan reproduksi serta menentukan apakah diperlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

1. Tujuan Sistem Rujukan

Sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan remaja.

- b. Memastikan remaja memperoleh penanganan yang tepat dan berkelanjutan.
- c. Mencegah terjadinya komplikasi yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi remaja.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui kerja sama antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan adanya sistem rujukan yang baik, pelayanan kesehatan reproduksi remaja dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.

2. Indikasi Rujukan pada Kesehatan Reproduksi Remaja

Bidan perlu melakukan rujukan apabila ditemukan kondisi kesehatan reproduksi pada remaja yang memerlukan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut. Beberapa kondisi yang memerlukan rujukan antara lain:

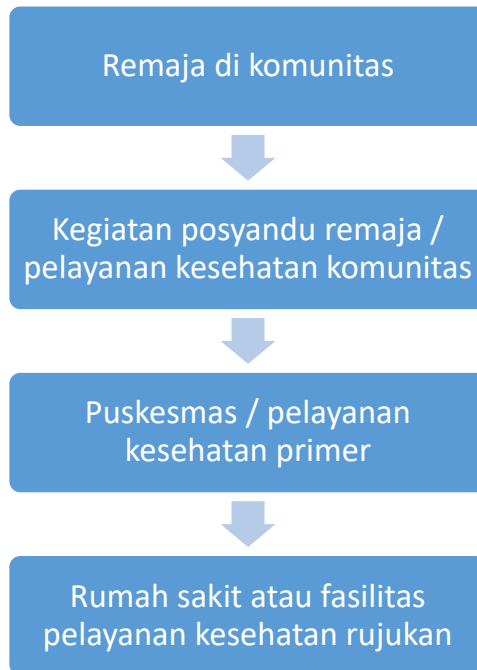
- a. Gangguan menstruasi yang berat atau berkepanjangan
- b. Nyeri haid yang sangat berat dan mengganggu aktivitas
- c. Dugaan infeksi menular seksual
- d. Keluhan keputihan yang tidak normal
- e. Kehamilan pada remaja
- f. Dugaan kekerasan seksual
- g. Masalah kesehatan mental yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi

Deteksi dini terhadap kondisi tersebut sangat penting agar remaja dapat segera memperoleh penanganan yang tepat.

3. Alur Rujukan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja

Dalam pelayanan kebidanan komunitas, alur rujukan kesehatan reproduksi remaja biasanya dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, seperti posyandu remaja atau puskesmas, kemudian dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap apabila diperlukan.

Secara umum alur rujukan dapat digambarkan sebagai berikut:



Alur rujukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa remaja mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan fasilitas kesehatan.

4. Peran Bidan dalam Sistem Rujukan

Bidan memiliki peran penting dalam pelaksanaan sistem rujukan kesehatan reproduksi remaja. Beberapa peran bidan dalam sistem rujukan antara lain:

- Melakukan pengkajian awal terhadap masalah kesehatan reproduksi remaja.
- Mengidentifikasi kondisi yang memerlukan rujukan.
- Memberikan penjelasan kepada remaja dan keluarga mengenai alasan rujukan.
- Menyiapkan dokumen rujukan yang diperlukan.
- Melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

Selain itu, bidan juga perlu melakukan tindak lanjut setelah rujukan dilakukan untuk memastikan bahwa remaja memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Melalui sistem rujukan yang baik, pelayanan kesehatan reproduksi remaja dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan remaja di komunitas.

G. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini Case (Diskusi Kasus)

Seorang remaja putri usia 16 tahun datang ke kegiatan posyandu remaja dengan keluhan nyeri haid yang cukup berat sejak beberapa bulan terakhir. Ia juga menyampaikan bahwa siklus menstruasinya tidak teratur. Remaja tersebut mengaku sering memperoleh informasi mengenai kesehatan reproduksi dari media sosial, namun tidak yakin apakah informasi tersebut benar. Ia merasa malu untuk bertanya kepada orang tua atau guru mengenai masalah tersebut.

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi masalah kesehatan reproduksi yang dialami oleh remaja pada kasus tersebut.
2. Faktor risiko apa saja yang mungkin mempengaruhi kondisi kesehatan reproduksi remaja tersebut?
3. Informasi kesehatan reproduksi apa yang perlu diberikan kepada remaja terkait keluhan nyeri haid dan siklus menstruasi yang tidak teratur?
4. Bagaimana cara bidan atau tenaga kesehatan memberikan edukasi yang tepat kepada remaja terkait informasi kesehatan yang diperoleh dari media sosial?
5. Jelaskan pendekatan komunikasi yang ramah remaja yang dapat digunakan saat melakukan konseling pada kasus tersebut.
6. Apakah kondisi pada kasus tersebut memerlukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan? Jelaskan alasan dan langkah rujukan yang dapat dilakukan.
7. Sebagai bidan di komunitas, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di posyandu remaja untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi?

H. Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Kesehatan Reproduksi Remaja di Komunitas: Edukasi dan Konseling
3	Kasus	Remaja dengan keluhan nyeri haid dan informasi kesehatan yang tidak tepat dari media sosial
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam memberikan edukasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja di komunitas serta menentukan kebutuhan tindak lanjut atau rujukan.
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan sederhana/pengkajian masalah Kesehatan 3. Perumusan diagnosis/masalah kebidanan 4. Edukasi kesehatan reproduksi remaja 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang remaja putri usia 16 tahun datang ke kegiatan Posyandu Remaja dengan keluhan nyeri haid yang cukup berat sejak beberapa bulan terakhir dan siklus menstruasi yang tidak teratur. Ia juga mengatakan sering mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dari media sosial, namun tidak yakin apakah informasi tersebut benar. Ia merasa malu untuk bertanya kepada orang tua atau guru. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pengkajian masalah kesehatan reproduksi yang dialami remaja. 3. Sampaikan diagnosis atau masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Berikan edukasi kesehatan reproduksi yang tepat sesuai kondisi remaja. 5. Berikan KIE singkat serta jelaskan rencana tindak lanjut atau rujukan jika diperlukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian.

		2. Tulislah nomor peserta sesuai ketentuan ujian. 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian menggunakan: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog. 2. Jika peserta meminta informasi tambahan mengenai siklus menstruasi, penguji memberikan data: - Menarche usia 12 tahun - Siklus menstruasi tidak teratur (30–45 hari) - Nyeri haid muncul pada hari pertama menstruasi 3. Jika peserta menanyakan kebiasaan atau perilaku kesehatan: - Remaja sering mencari informasi kesehatan melalui media sosial - Belum pernah mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi secara formal 4. Edukasi yang diharapkan dari peserta meliputi: - Penjelasan tentang menstruasi dan nyeri haid - Cara menjaga kesehatan reproduksi remaja - Klarifikasi informasi kesehatan dari media sosial - Anjuran berkonsultasi jika keluhan menetap 5. Penguji hanya memberikan data tambahan jika diminta peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai remaja usia 16 tahun. 2. PS tampak sedikit malu dan ragu saat membicarakan masalah menstruasi. 3. Jika peserta menjelaskan dengan baik, PS menjadi lebih terbuka dan kooperatif. 4. Jika peserta memberikan edukasi atau saran, PS mendengarkan dan menanggapi dengan positif.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi. PS: Pagi, Kak Peserta: Apa yang bisa saya bantu? PS: Saya sering sakit perut kalau haid, dan haid saya juga tidak teratur. Peserta: Sejak kapan keluhan tersebut terjadi? PS: Sudah beberapa bulan terakhir.

		Peserta: Apakah kamu pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi sebelumnya? PS: Saya sering lihat di media sosial, tapi tidak tahu apakah benar atau tidak. Peserta: Apakah kamu pernah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelumnya? PS: Belum, saya agak malu. Peserta: Saya akan memberikan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi dan cara mengurangi nyeri haid. PS: Baik, Kak
10	Kebutuhan manikin	Tidak diperlukan manikin khusus. Simulasi menggunakan standardized patient (PS)
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1. Menyiapkan ruang OSCE 2. Menyiapkan lembar penilaian 3. Mengatur pergantian peserta
12	Kebutuhan alat	1. Meja dan kursi konsultasi 2. Lembar instruksi peserta 3. Lembar penilaian penguji 4. Pena
13	Penulis	
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan RI. (2020). Standar Profesi Bidan. 2. Kementerian Kesehatan RI. (2022). Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan. 3. World Health Organization. (2018). Adolescent sexual and reproductive health. 4. BKKBN. (2020). Kesehatan reproduksi remaja

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Kesehatan Reproduksi Remaja di Komunitas

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama remaja		
2. Riwayat menstruasi (menarche, siklus, lama, keluhan nyeri haid)		
3. Riwayat keluhan kesehatan reproduksi (keputihan, nyeri perut, gangguan siklus)		
4. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi		
5. Sumber informasi kesehatan reproduksi (media sosial, teman, sekolah, tenaga kesehatan)		
6. Perilaku kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi		

7. Riwayat kesehatan atau penyakit yang relevan		
8. Dukungan keluarga atau lingkungan terhadap kesehatan remaja		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Pengkajian Masalah

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Mengidentifikasi masalah kesehatan reproduksi remaja		
2. Mengidentifikasi faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan reproduksi		
3. Menentukan kebutuhan edukasi kesehatan reproduksi		
4. Menentukan apakah diperlukan tindak lanjut atau rujukan		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Semua langkah dilakukan dengan benar.
- 2= Sebagian besar langkah dilakukan dengan benar.
- 1= Hanya sebagian kecil langkah dilakukan.
- 0= Tidak melakukan pengkajian.

KOMPETENSI 3. Edukasi dan Konseling (KIE)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Menjelaskan kondisi kesehatan reproduksi remaja dengan bahasa yang mudah dipahami		
Memberikan edukasi tentang menstruasi dan nyeri haid		
Meluruskan informasi kesehatan yang salah dari media sosial		
Memberikan saran menjaga kesehatan reproduksi		
Menggunakan komunikasi yang ramah remaja		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Semua langkah dilakukan dengan benar.
- 2= Sebagian besar langkah dilakukan dengan benar.
- 1= Hanya sebagian kecil langkah dilakukan.

KOMPETENSI 4. Tindak Lanjut / Rujukan

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Menjelaskan kemungkinan tindak lanjut		
Mengidentifikasi kondisi yang memerlukan rujukan		
Menjelaskan rencana rujukan kepada klien		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Semua langkah dilakukan dengan benar.
- 2= Sebagian langkah dilakukan dengan benar.
- 1= Hanya satu langkah dilakukan.
- 0= Tidak melakukan.

KOMPETENSI 5. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama kontraksi/nyeri		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

Kriteria Kelulusan

Peserta dinyatakan kompeten apabila:

- Tidak gagal pada critical items (keselamatan klien, privasi, komunikasi profesional).
- Skor total minimal mencapai batas kelulusan yang ditentukan institusi.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

I. Aktivitas 2 — *Shows How*

Mahasiswa melakukan simulasi konseling kesehatan reproduksi remaja di komunitas dengan fokus pada edukasi, pencegahan risiko, serta penentuan kebutuhan rujukan.

Skenario Singkat OSCE

Seorang remaja putri usia 16 tahun datang ke kegiatan posyandu remaja dengan keluhan siklus menstruasi tidak teratur dan ingin mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi. Mahasiswa diminta melakukan edukasi dan konseling **singkat** serta menentukan apakah diperlukan rujukan.

Mahasiswa diharapkan mampu:

1. melakukan komunikasi yang ramah remaja
2. memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang benar
3. mengidentifikasi faktor risiko
4. menentukan kebutuhan rujukan jika ditemukan masalah kesehatan

Critical Items (WAJIB LULUS)

Mahasiswa harus melakukan langkah berikut secara benar. Jika salah satu tidak dilakukan, mahasiswa **tidak lulus OSCE**.

1. Memperkenalkan diri dan memastikan identitas klien, serta menjaga privasi remaja selama proses konseling.
2. Membangun komunikasi yang aman dan tidak menghakimi, sehingga remaja merasa nyaman untuk menyampaikan masalah kesehatan reproduksi.
3. Memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang benar, termasuk pencegahan perilaku berisiko dan cara menjaga kesehatan reproduksi.
4. Mengidentifikasi tanda atau kondisi yang memerlukan rujukan, seperti keluhan kesehatan reproduksi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas kesehatan.
5. Menjelaskan tindak lanjut atau rujukan dengan jelas kepada remaja dan memastikan klien memahami informasi yang diberikan.

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan klien & privasi	Menjaga privasi remaja, komunikasi aman, menghormati kerahasiaan, dan mengikuti prinsip etika secara konsisten	Ada kekurangan kecil namun tidak mengganggu keselamatan atau privasi	Ada risiko kecil pada privasi atau kenyamanan klien	Tidak menjaga privasi, komunikasi tidak etis, atau berpotensi membahayakan klien
Asesmen & keputusan	Mengidentifikasi masalah kesehatan reproduksi secara tepat, menentukan edukasi dan kebutuhan rujukan dengan jelas	Identifikasi masalah cukup tepat, keputusan masih memerlukan sedikit arahan	Asesmen kurang lengkap dan keputusan ragu-ragu	Salah mengidentifikasi masalah atau keputusan tidak tepat
Komunikasi & konseling	Komunikasi empatik, ramah remaja, jelas, dan mampu membangun kepercayaan	Komunikasi baik namun kurang eksplorasi kebutuhan klien	Komunikasi kurang jelas atau kurang empatik	Komunikasi buruk, tidak responsif terhadap klien

Catatan untuk penulis:

1. Penilaian harus memperhatikan aspek keselamatan klien dan etika pelayanan sebagai prioritas utama.
2. Nilai tinggi pada aspek lain tidak menutup kegagalan pada aspek keselamatan atau privasi klien. Jika terjadi pelanggaran serius terhadap keselamatan atau etika, mahasiswa tidak dapat dinyatakan lulus meskipun nilai total cukup tinggi.
3. Rubrik ini digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan edukasi, konseling, serta pengambilan keputusan rujukan pada kesehatan reproduksi remaja di komunitas.

J. Red Flags (Tanda Bahaya)

Remaja perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan apabila ditemukan kondisi berikut:

1. nyeri haid yang sangat berat dan mengganggu aktivitas
2. gangguan menstruasi berkepanjangan
3. dugaan infeksi menular seksual
4. keputihan yang tidak normal
5. kehamilan pada remaja
6. dugaan kekerasan seksual

K. Form Checklist “Saya Sudah Bisa”

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep kesehatan reproduksi remaja
2. Mengidentifikasi masalah kesehatan reproduksi pada remaja
3. Memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja
4. Melakukan konseling kesehatan reproduksi secara efektif
5. Menentukan kebutuhan rujukan pada masalah kesehatan reproduksi remaja

L. Template Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Kesehatan Reproduksi Remaja di Komunitas: Edukasi dan Konseling
3	Kasus	Remaja dengan keluhan nyeri haid dan informasi kesehatan yang tidak tepat dari media sosial
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam memberikan edukasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja di komunitas serta menentukan kebutuhan tindak lanjut atau rujukan.
5	Kompetensi	8. Anamnesis 9. Pemeriksaan sederhana/pengkajian masalah Kesehatan 10. Perumusan diagnosis/masalah kebidanan 11. Edukasi kesehatan reproduksi remaja 12. KIE/konseling 13. Kolaborasi/rujukan 14. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang remaja putri usia 16 tahun datang ke kegiatan Posyandu Remaja dengan keluhan nyeri haid yang cukup berat sejak beberapa bulan terakhir dan siklus menstruasi yang tidak

		teratur. Ia juga mengatakan sering mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dari media sosial, namun tidak yakin apakah informasi tersebut benar. Ia merasa malu untuk bertanya kepada orang tua atau guru. TUGAS 6. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 7. Lakukan pengkajian masalah kesehatan reproduksi yang dialami remaja. 8. Sampaikan diagnosis atau masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 9. Berikan edukasi kesehatan reproduksi yang tepat sesuai kondisi remaja. 10. Berikan KIE singkat serta jelaskan rencana tindak lanjut atau rujukan jika diperlukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 4. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 5. Tulislah nomor peserta sesuai ketentuan ujian. 6. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian menggunakan: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. INSTRUKSI KHUSUS 3. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog. 4. Jika peserta meminta informasi tambahan mengenai siklus menstruasi, penguji memberikan data: - Menarche usia 12 tahun - Siklus menstruasi tidak teratur (30–45 hari) - Nyeri haid muncul pada hari pertama menstruasi 4. Jika peserta menanyakan kebiasaan atau perilaku kesehatan: - Remaja sering mencari informasi kesehatan melalui media sosial - Belum pernah mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi secara formal 5. Edukasi yang diharapkan dari peserta meliputi: - Penjelasan tentang menstruasi dan nyeri haid - Cara menjaga kesehatan reproduksi remaja - Klarifikasi informasi kesehatan dari media sosial - Anjuran berkonsultasi jika keluhan menetap

		6. Penguji hanya memberikan data tambahan jika diminta peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 5. PS berperan sebagai remaja usia 16 tahun. 6. PS tampak sedikit malu dan ragu saat membicarakan masalah menstruasi. 7. Jika peserta menjelaskan dengan baik, PS menjadi lebih terbuka dan kooperatif. 8. Jika peserta memberikan edukasi atau saran, PS mendengarkan dan menanggapi dengan positif.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi. PS: Pagi, Kak Peserta: Apa yang bisa saya bantu? PS: Saya sering sakit perut kalau haid, dan haid saya juga tidak teratur. Peserta: Sejak kapan keluhan tersebut terjadi? PS: Sudah beberapa bulan terakhir. Peserta: Apakah kamu pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi sebelumnya? PS: Saya sering lihat di media sosial, tapi tidak tahu apakah benar atau tidak. Peserta: Apakah kamu pernah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelumnya? PS: Belum, saya agak malu. Peserta: Saya akan memberikan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi dan cara mengurangi nyeri haid. PS: Baik, Kak
10	Kebutuhan manikin	Tidak diperlukan manikin khusus. Simulasi menggunakan standardized patient (PS)
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 4. Menyiapkan ruang OSCE 5. Menyiapkan lembar penilaian 6. Mengatur pergantian peserta
12	Kebutuhan alat	5. Meja dan kursi konsultasi 6. Lembar instruksi peserta 7. Lembar penilaian penguji 8. Pena
13	Penulis	
14	Referensi	5. Kementerian Kesehatan RI. (2020). Standar Profesi Bidan. 6. Kementerian Kesehatan RI. (2022). Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan.

		7. World Health Organization. (2018). Adolescent sexual and reproductive health. 8. BKKBN. (2020). Kesehatan reproduksi remaja
--	--	--

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Kesehatan Reproduksi Remaja di Komunitas

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Keluhan utama remaja		
Riwayat menstruasi (menarche, siklus, lama, keluhan nyeri haid)		
Riwayat keluhan kesehatan reproduksi (keputihan, nyeri perut, gangguan siklus)		
Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi		
Sumber informasi kesehatan reproduksi (media sosial, teman, sekolah, tenaga kesehatan)		
Perilaku kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi		
Riwayat kesehatan atau penyakit yang relevan		
Dukungan keluarga atau lingkungan terhadap kesehatan remaja		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Pengkajian Masalah

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
5. Mengidentifikasi masalah kesehatan reproduksi remaja		
6. Mengidentifikasi faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan reproduksi		
7. Menentukan kebutuhan edukasi kesehatan reproduksi		
8. Menentukan apakah diperlukan tindak lanjut atau rujukan		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Semua langkah dilakukan dengan benar.
- 2= Sebagian besar langkah dilakukan dengan benar.
- 1= Hanya sebagian kecil langkah dilakukan.
- 0= Tidak melakukan pengkajian.

KOMPETENSI 3. Edukasi dan Konseling (KIE)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Menjelaskan kondisi kesehatan reproduksi remaja dengan bahasa yang mudah dipahami		
Memberikan edukasi tentang menstruasi dan nyeri haid		
Meluruskan informasi kesehatan yang salah dari media sosial		
Memberikan saran menjaga kesehatan reproduksi		
Menggunakan komunikasi yang ramah remaja		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Semua langkah dilakukan dengan benar.
- 2= Sebagian besar langkah dilakukan dengan benar.
- 1= Hanya sebagian kecil langkah dilakukan.

KOMPETENSI 4. Tindak Lanjut / Rujukan

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Menjelaskan kemungkinan tindak lanjut		
Mengidentifikasi kondisi yang memerlukan rujukan		
Menjelaskan rencana rujukan kepada klien		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Semua langkah dilakukan dengan benar.
- 2= Sebagian langkah dilakukan dengan benar.
- 1= Hanya satu langkah dilakukan.
- 0= Tidak melakukan.

KOMPETENSI 5. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama kontraksi/nyeri		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 5

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

Kriteria Kelulusan

Peserta dinyatakan kompeten apabila:

1. Tidak gagal pada critical items (keselamatan klien, privasi, komunikasi profesional).
2. Skor total minimal mencapai batas kelulusan yang ditentukan institusi.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

M. DOPS di Lahan Praktik

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) dilakukan di lahan praktik komunitas, seperti posyandu remaja, sekolah, atau kegiatan kesehatan masyarakat, untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memberikan edukasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja secara langsung.

Kegiatan penilaian meliputi:

1. Observasi langsung kegiatan edukasi atau konseling kesehatan reproduksi remaja oleh mahasiswa di komunitas.
2. Penilaian menggunakan checklist observasi, yang mencakup kemampuan komunikasi, penyampaian materi edukasi, identifikasi faktor risiko, serta penentuan kebutuhan rujukan.
3. Umpan balik singkat dari pembimbing praktik setelah kegiatan untuk membantu mahasiswa memperbaiki keterampilan komunikasi dan pendekatan kepada remaja.

Hasil penilaian biasanya dikategorikan menjadi:

1. Kompeten
2. Perlu supervisi
3. Remedial

N. Catatan untuk Penilai

1. Penilaian DOPS dilakukan setelah mahasiswa melewati tahap simulasi atau OSCE, sehingga mahasiswa sudah memiliki dasar keterampilan sebelum praktik di komunitas.
2. DOPS bertujuan untuk menilai performa nyata mahasiswa dalam situasi praktik, sehingga memberikan gambaran kemampuan mahasiswa dalam menerapkan edukasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja di lapangan.

O. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

P. Ringkasan Materi

Bab ini membahas konsep kesehatan reproduksi remaja serta berbagai perubahan yang terjadi pada masa remaja yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan, perilaku berisiko, serta pengaruh lingkungan sosial.

Upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja dapat dilakukan melalui edukasi kesehatan reproduksi, promosi kesehatan, serta pencegahan risiko yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Selain itu, sistem rujukan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa remaja memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Bidan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, konseling, serta melakukan deteksi dini dan rujukan pada masalah kesehatan reproduksi remaja di komunitas.

Q. Referensi

- Bastable, S. B., Sopczyk, D., Gramet, P., & Jacobs, K. (2020). *Health professional as educator: Principles of teaching and learning* (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Chandra-Mouli, V., Lane, C., & Wong, S. (2021). What does not work in adolescent sexual and reproductive health: A review of evidence. *Journal of Adolescent Health, 69*(2), 240–250. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.04.010>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar profesi bidan* (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020). Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelayanan kesehatan reproduksi remaja*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar kompetensi kerja bidang kebidanan* (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022). Kementerian Kesehatan RI.
- Santrock, J. W. (2019). *Adolescence* (16th ed.). McGraw-Hill Education.
- United Nations Population Fund. (2020). *Adolescent sexual and reproductive health toolkit for humanitarian settings*. UNFPA.
- Widman, L., Nesi, J., Kamke, K., Choukas-Bradley, S., & Stewart, J. L. (2018). Technology-based interventions to reduce sexually transmitted infections and unintended pregnancy among youth. *Journal of*

Adolescent Health, 62(6), 651–660. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.12.007>

World Health Organization. (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. WHO.

World Health Organization. (2020). *Sexual and reproductive health and rights*. World Health Organization.

World Health Organization. (2022). *Adolescent health and development*. World Health Organization.

World Health Organization. (2023). *Global accelerated action for the health of adolescents (AA-HA!): Guidance to support country implementation*. World Health Organization.

BAB 3

KELUARGA BERENCANA DI TINGKAT KOMUNITAS: PELAYANAN, JEJARING, DAN TINDAK LANJUT

Capaian Pembelajaran Lulusan

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, kebijakan, dan prinsip pelayanan kebidanan komunitas serta pelayanan KIA primer berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian kebutuhan dan masalah KIA pada keluarga/komunitas menggunakan data, surveilans, dan analisis prioritas.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-7
CPL-3	Mampu merencanakan dan memberikan asuhan kebidanan berbasis keluarga sepanjang siklus kehidupan dengan kesinambungan layanan (continuity of care).	CPMK-2; CPMK-6
CPL-4	Mampu mengorganisasi dan mengelola layanan KIA berbasis komunitas (Posyandu/UKBM, layanan terpadu) serta membangun jejaring rujukan dan kemitraan.	CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Mampu melakukan komunikasi efektif, KIE, promosi kesehatan, pemberdayaan kader/masyarakat, dan pendekatan sensitif budaya.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-2
CPL-6	Menunjukkan profesionalisme, etika, keselamatan, serta kemampuan monitoring-evaluasi dan perbaikan mutu program KIA.	CPMK-1; CPMK-7; CPMK-3

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menguasai konsep, kebijakan dasar, dan peran profesi dalam kebidanan komunitas serta prinsip etika–keselamatan di pelayanan primer.
CPMK-2	Menerapkan pendekatan keluarga dan siklus kehidupan dalam perencanaan serta pelaksanaan asuhan kebidanan berbasis keluarga dan kesinambungan layanan.
CPMK-3	Menganalisis data KIA dan surveilans untuk pemetaan masalah, penetapan prioritas, serta perencanaan intervensi berbasis bukti.
CPMK-4	Merancang dan mengelola penyelenggaraan layanan KIA berbasis komunitas (Posyandu/UKBM dan layanan terpadu) termasuk pembinaan kader dan jejaring rujukan.
CPMK-5	Melaksanakan KIE/promosi kesehatan dan intervensi gizi ibu–bayi–balita di komunitas dengan strategi perubahan perilaku yang terukur.
CPMK-6	Melakukan edukasi, konseling, dan tindak lanjut layanan kesehatan reproduksi remaja serta keluarga berencana di komunitas secara berpusat pada klien.
CPMK-7	Menyusun strategi pencegahan–penanggulangan masalah KIA prioritas, kesiapsiagaan rujukan, kolaborasi lintas sektor, serta monitoring-evaluasi program.

Uraian Materi

Keluarga Berencana (KB) merupakan komponen strategis dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga di Indonesia. Konsep KB tidak hanya berkaitan dengan pengaturan jumlah dan jarak kelahiran, tetapi juga berakar pada teori kesehatan reproduksi yang menempatkan hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Teori hak reproduksi menegaskan bahwa setiap individu berhak menentukan pilihan reproduksinya secara bebas, bertanggung jawab, dan bermartabat (WHO, 2021). Kebijakan nasional menempatkan KB sebagai instrumen pembangunan keluarga berkualitas melalui pengendalian fertilitas, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan fungsi keluarga (BKKBN, 2022). Kontribusi program KB terhadap penurunan angka kematian ibu, pencegahan kehamilan risiko tinggi, dan pengendalian Total Fertility Rate didukung oleh pendekatan kesehatan masyarakat berbasis pencegahan primer (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Pelayanan KB dalam kebidanan komunitas dipahami melalui teori *continuity of care* yang menekankan kesinambungan asuhan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Teori ini menyatakan bahwa kualitas pelayanan meningkat ketika intervensi kesehatan diberikan secara berkelanjutan dan terintegrasi, mulai dari masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga periode antar kehamilan (Saifuddin, 2020). Kerangka siklus kehidupan (*life cycle approach*) menempatkan KB sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan ibu dan keluarga secara menyeluruh. Pelayanan KB dengan demikian tidak berdiri sebagai tindakan klinis semata, melainkan sebagai bagian dari perencanaan asuhan kebidanan berbasis keluarga yang sistematis dan terdokumentasi.

Kerangka pembelajaran dalam bab ini disusun selaras dengan CPMK-6 yang menekankan kemampuan melakukan edukasi, konseling, dan tindak lanjut layanan kesehatan reproduksi secara berpusat pada klien. Landasan teoritis yang digunakan merujuk pada teori *client-centered care* dari Carl Rogers yang menekankan empati, penerimaan tanpa syarat, dan penghormatan terhadap otonomi klien dalam proses pengambilan keputusan (Rogers, 1961). Konsep *shared decision making* memperkuat pendekatan tersebut dengan melibatkan klien secara aktif dalam menentukan pilihan kontrasepsi berdasarkan informasi yang lengkap dan seimbang (Elwyn et al., 2012). Praktik profesional dalam pelayanan KB mencakup konseling berbasis hak, dokumentasi keputusan klien, penyusunan rencana tindak lanjut terjadwal, serta monitoring efek samping dan kepatuhan penggunaan metode.

Pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menjadi fondasi etis dalam pelayanan KB komunitas. Prinsip ini menekankan ketersediaan informasi, akses tanpa diskriminasi, keamanan pelayanan, privasi, dan kebebasan dari paksaan (WHO, 2021). Teori etika pelayanan kesehatan menggarisbawahi prinsip otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice sebagai pedoman praktik profesional (Beauchamp & Childress, 2019). Penerapan prinsip tersebut dalam konseling KB mengharuskan bidan memberikan informasi akurat, menilai kondisi medis secara objektif, serta memastikan keputusan klien dihormati dan didokumentasikan (Marmi, 2021).

Penguatan CPMK-4 tercermin melalui teori manajemen pelayanan kesehatan primer yang menekankan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan layanan berbasis komunitas (Green & Kreuter, 2005). Pelayanan KB di Posyandu, Puskesmas, dan UKBM memerlukan tata kelola yang jelas, sistem pencatatan yang akurat, ketersediaan logistik, serta mekanisme rujukan dua arah yang terdokumentasi. Teori sistem kesehatan menyatakan bahwa keberhasilan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga oleh integrasi komponen sistem seperti sumber daya, regulasi, dan jejaring kemitraan (WHO, 2010). Peran bidan dalam konteks ini meliputi pengelolaan alur pelayanan, koordinasi lintas sektor, serta pembinaan kader sebagai bagian dari manajemen layanan berbasis komunitas.

Kesesuaian dengan CPMK-2 diperkuat melalui teori family-centered care yang menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam perencanaan asuhan (Friedman, Bowden, & Jones, 2003). Teori ini menekankan bahwa keputusan kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh dinamika keluarga, nilai budaya, dan dukungan pasangan. Pendekatan ekologi sosial dari Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perilaku reproduksi individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu, keluarga, komunitas, dan kebijakan (Bronfenbrenner, 1979). Perencanaan metode kontrasepsi karena itu harus mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya secara terintegrasi.

Evaluasi keberhasilan program KB tidak hanya mengacu pada indikator kuantitatif seperti CPR dan peningkatan penggunaan MKJP, tetapi juga pada teori mutu pelayanan kesehatan yang menekankan aspek struktur, proses, dan outcome (Donabedian, 1988). Mutu konseling, ketepatan pemilihan metode, efektivitas tindak lanjut, serta sistem rujukan yang responsif menjadi indikator penting dalam menjamin keberlanjutan pelayanan (BKKBN, 2022). Fenomena

drop out dan unmet need menunjukkan perlunya penguatan kompetensi komunikasi, monitoring, dan manajemen layanan berbasis komunitas.

Bab ini disusun untuk mengintegrasikan teori kesehatan reproduksi, teori asuhan berkesinambungan, teori konseling berpusat pada klien, serta teori manajemen layanan kesehatan primer dalam konteks praktik kebidanan komunitas. Integrasi teori dan praktik tersebut diharapkan membentuk kerangka berpikir kritis dan keterampilan aplikatif mahasiswa dalam mengimplementasikan pelayanan KB yang profesional, etis, berpusat pada klien, serta berkelanjutan di tingkat komunitas

A. Konsep Keluarga Berencana Berbasis Komunitas

1. Konsep dan Definisi

Keluarga Berencana (KB) didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk mengatur jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak melalui penggunaan metode kontrasepsi yang aman dan efektif guna mewujudkan keluarga berkualitas (BKKBN, 2022). Definisi ini menempatkan KB tidak hanya sebagai intervensi klinis, tetapi sebagai strategi pembangunan kesehatan reproduksi yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perspektif kesehatan masyarakat memandang KB sebagai bentuk pencegahan primer terhadap risiko kehamilan yang tidak direncanakan, kehamilan terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jaraknya, dan terlalu banyak jumlahnya (4T) yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Konsep ini diperkuat oleh teori determinan kesehatan yang menyatakan bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh faktor perilaku, lingkungan sosial, pelayanan kesehatan, dan kebijakan publik (Green & Kreuter, 2005).

Pendekatan komunitas dalam KB berlandaskan pada teori *family-centered care* dan pendekatan ekologi sosial. Teori *family-centered care* menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam pengambilan keputusan kesehatan, sehingga pelayanan KB harus mempertimbangkan dinamika keluarga, nilai budaya, dan dukungan pasangan (Friedman et al., 2003). Pendekatan ekologi sosial menjelaskan bahwa perilaku penggunaan kontrasepsi dipengaruhi oleh interaksi antara individu, keluarga, komunitas, dan sistem pelayanan kesehatan (Bronfenbrenner, 1979).

Pelayanan KB berbasis komunitas dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Berbasis keluarga, yaitu perencanaan kontrasepsi mempertimbangkan kondisi kesehatan, sosial, dan psikologis keluarga.
- b. Berpusat pada klien, dengan menghormati otonomi dan pilihan individu.
- c. Berkelanjutan (*continuity of care*), melalui asuhan yang terintegrasi sepanjang siklus kehidupan perempuan (Saifuddin, 2020).
- d. Menghormati hak reproduksi, sesuai prinsip *rights-based approach* yang menjamin akses informasi, keamanan pelayanan, dan kebebasan dari paksaan (WHO, 2021).

Pendekatan berbasis hak menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh informasi lengkap dan tidak bias, memilih metode secara sukarela, serta mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu. Prinsip otonomi dan keadilan dalam etika kesehatan memperkuat kewajiban bidan untuk memastikan adanya *informed choice* dalam setiap proses konseling (Beauchamp & Childress, 2019).

2. Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional KB di Indonesia dilaksanakan melalui sinergi antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan. Program Bangga Kencana menekankan pembangunan keluarga sebagai fondasi pembangunan nasional dengan strategi peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB (BKKBN, 2022).

Fokus kebijakan nasional meliputi:

- a. Penurunan *unmet need*, yaitu kondisi ketika pasangan ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi.
- b. Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebagai metode dengan efektivitas tinggi dan angka kegagalan rendah.
- c. Integrasi KB pasca persalinan dan pasca keguguran, sebagai bagian dari strategi pencegahan kehamilan risiko tinggi.
- d. Penguatan pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas dan praktik mandiri bidan, guna memperluas akses pelayanan.

Pendekatan ini selaras dengan teori sistem kesehatan yang menyatakan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh integrasi kebijakan, sumber daya manusia, logistik, serta sistem rujukan yang efektif (WHO, 2010). Kebijakan nasional juga menekankan pentingnya pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan, bukan sekadar peningkatan angka cakupan.

3. Peran Bidan Komunitas

Bidan komunitas memiliki peran strategis dalam implementasi KB berbasis komunitas. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pemberian kontrasepsi, tetapi mencakup fungsi edukatif, manajerial, dan koordinatif.

Bidan berperan sebagai:

- a. Edukator dan konselor, dengan menerapkan teori komunikasi terapeutik dan pendekatan client-centered care (Rogers, 1961).
- b. Penyedia layanan kontrasepsi, termasuk skrining medis, pemasangan MKJP, dan penanganan efek samping ringan.
- c. Penggerak kader dan tokoh masyarakat, melalui pemberdayaan komunitas untuk meningkatkan literasi kesehatan reproduksi.
- d. Koordinator tindak lanjut dan rujukan, memastikan continuity of care dan dokumentasi yang akurat.

Peran ini mencerminkan integrasi kompetensi CPMK-6 (konseling dan tindak lanjut), CPMK-4 (pengelolaan layanan dan jejaring), serta CPMK-2 (pendekatan keluarga dan siklus kehidupan).

4. Contoh Implementasi di Lapangan

Implementasi KB berbasis komunitas dapat dilihat pada praktik di desa dengan cakupan KB pasca persalinan yang rendah. Bidan bersama kader melakukan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS), mengidentifikasi kelompok dengan unmet need, dan menyelenggarakan kelas ibu nifas yang membahas pilihan kontrasepsi pasca persalinan.

Pendekatan tersebut menggunakan teori perubahan perilaku Health Belief Model yang menyatakan bahwa individu cenderung mengambil tindakan kesehatan jika memahami risiko dan manfaat intervensi (Rosenstock, 1974). Edukasi yang diberikan meningkatkan persepsi manfaat KB dan menurunkan hambatan akibat mitos. Hasilnya terlihat pada peningkatan penggunaan KB postpartum dalam tiga bulan pertama setelah persalinan.

5. Tantangan dan Solusi

Pelaksanaan KB berbasis komunitas menghadapi berbagai tantangan, baik pada tingkat individu maupun sistem.

Tantangan utama meliputi:

- a. Mitos dan stigma terhadap metode tertentu, terutama MKJP.
- b. Akses terbatas terhadap layanan pemasangan MKJP di wilayah terpencil.
- c. Kepatuhan rendah dan angka putus pakai (drop out).

Faktor budaya dan norma sosial sering memengaruhi keputusan penggunaan kontrasepsi. Teori ekologi sosial menjelaskan bahwa intervensi harus dilakukan pada berbagai tingkat, tidak hanya individu (Bronfenbrenner, 1979).

Solusi yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Edukasi berbasis budaya dan melibatkan tokoh masyarakat untuk meningkatkan penerimaan sosial.
- b. Pelayanan jemput bola melalui pelayanan keliling atau kunjungan rumah.
- c. Monitoring aktif melalui sistem pencatatan dan kunjungan ulang terjadwal untuk menekan angka drop out.

Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan teori perubahan perilaku, manajemen layanan primer, serta prinsip hak reproduksi menjadi kunci dalam memperkuat pelayanan KB berbasis komunitas yang berkelanjutan dan bermutu.

B. Pelayanan KB di Tingkat Primer dan Komunitas

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di tingkat primer dan komunitas merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada akses, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep pelayanan primer merujuk pada teori Primary Health Care yang menekankan akses universal, partisipasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, dan penggunaan teknologi tepat guna (WHO, 1978). Pelayanan KB di Puskesmas, Posyandu, dan praktik mandiri bidan menjadi bentuk implementasi konkret dari prinsip tersebut dalam konteks kesehatan reproduksi.

1. Konsep Pelayanan KB di Tingkat Primer

Pelayanan KB di tingkat primer mencakup rangkaian proses yang sistematis, dimulai dari pengkajian, konseling, pemilihan metode, tindakan pelayanan, edukasi lanjutan, hingga tindak lanjut dan rujukan bila diperlukan. Model ini selaras dengan teori proses asuhan kebidanan yang terdiri dari pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Pelayanan primer menekankan prinsip *accessibility*, *continuity*, *comprehensiveness*, dan *coordination of care* (Starfield, 1998). *Accessibility* berarti layanan mudah dijangkau secara geografis dan finansial. *Continuity of care* memastikan klien memperoleh asuhan berkesinambungan. *Comprehensiveness* mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. *Coordination of care* menegaskan pentingnya sistem rujukan yang efektif.

Dalam konteks kebidanan komunitas, pelayanan KB di tingkat primer tidak hanya berfokus pada tindakan klinis, tetapi juga pada upaya promotif dan preventif melalui KIE, kelas ibu, kunjungan rumah, serta pemberdayaan kader.

Tabel 3.1
Jenis Metode Kontrasepsi dan Karakteristiknya

Metode	Jenis	Durasi	Kelebihan	Keterbatasan
Pil	Hormonal	Harian	Mudah digunakan	Perlu kepatuhan tinggi
Suntik	Hormonal	1–3 bulan	Praktis	Gangguan haid
IUD	MKJP	5–10 tahun	Efektif tinggi	Perlu tindakan medis
Implan	MKJP	3–5 tahun	Sangat efektif	Perlu pemasangan khusus
Kondom	Barrier	Sekali pakai	Cegah IMS	Tergantung penggunaan

2. Kebijakan dan Standar Nasional Pelayanan KB

Kebijakan nasional menempatkan pelayanan KB sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Standar pelayanan mencakup skrining medis sebelum pemilihan metode, penggunaan Kriteria Kelayakan Medis (*Medical Eligibility Criteria*), pencatatan dalam register KB, serta mekanisme rujukan untuk kasus dengan komplikasi (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

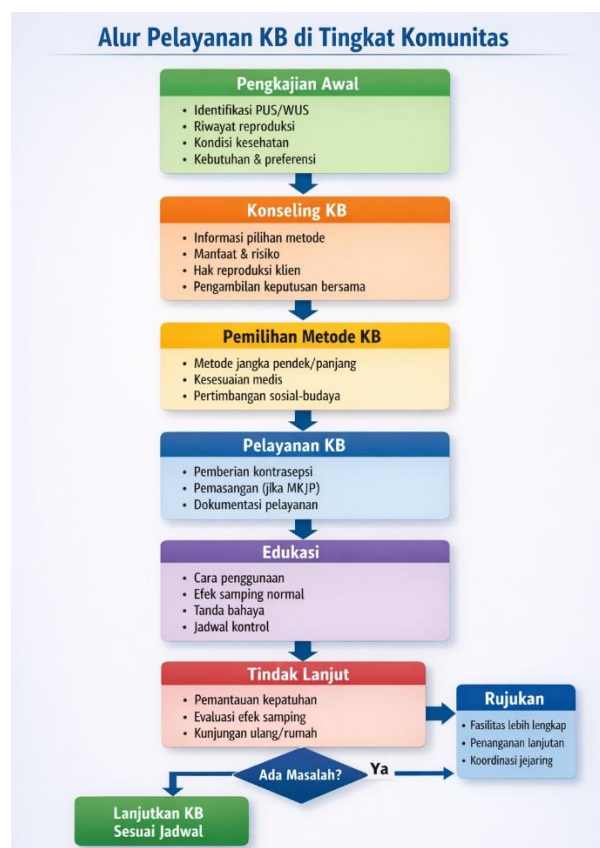
Program nasional mendorong peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) karena efektivitasnya yang tinggi dan angka kegagalan yang rendah (BKKBN, 2022). Integrasi pelayanan KB pasca

persalinan dan pasca keguguran juga menjadi prioritas kebijakan untuk menekan risiko kehamilan berulang dalam waktu singkat.

Pendekatan kebijakan ini selaras dengan teori *evidence-based practice* yang menekankan penggunaan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan klinis (Sackett et al., 1996). Bidan wajib memastikan bahwa pilihan metode didasarkan pada kondisi medis klien, bukan pada preferensi penyedia layanan.

3. Alur Pelayanan KB di Tingkat Komunitas

Pelayanan KB di tingkat komunitas mengikuti alur sistematis:



Gambar 3.1

Alur Pelayanan KB

Pengkajian meliputi identifikasi riwayat kesehatan, kondisi obstetri, kebutuhan reproduksi, serta faktor sosial budaya. Tahap konseling dilakukan dengan pendekatan client-centered care dan shared decision making (Rogers, 1961; Elwyn et al., 2012). Pemilihan metode dilakukan berdasarkan informed choice dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan medis.

Pelayanan tindakan dilakukan sesuai standar prosedur operasional, termasuk prinsip pencegahan infeksi dan keselamatan pasien. Edukasi

setelah tindakan bertujuan menjelaskan efek samping normal, tanda bahaya, serta jadwal kontrol ulang. Tindak lanjut dilakukan melalui kunjungan ulang atau pemantauan berbasis kader.

Model ini menunjukkan integrasi CPMK-6 melalui konseling dan tindak lanjut, CPMK-4 melalui pengelolaan alur pelayanan, serta CPMK-2 melalui pendekatan keluarga dan kesinambungan layanan.

4. Peran Bidan dalam Pelayanan Primer KB

Peran bidan dalam pelayanan primer mencerminkan fungsi klinis dan manajerial. Fungsi klinis mencakup skrining medis, pemasangan dan pelepasan MKJP, pemberian kontrasepsi hormonal, serta penanganan efek samping ringan. Fungsi manajerial mencakup pengelolaan logistik, pencatatan dan pelaporan, pembinaan kader, serta koordinasi rujukan.

Teori manajemen pelayanan kesehatan menyatakan bahwa mutu pelayanan dipengaruhi oleh struktur, proses, dan *outcome* (Donabedian, 1988). Struktur meliputi fasilitas dan logistik. Proses mencakup konseling dan tindakan klinis. *Outcome* terlihat dari kepuasan klien, kepatuhan, dan keberlanjutan penggunaan metode.

Bidan komunitas juga bertindak sebagai agen perubahan perilaku dengan menerapkan teori *Health Belief Model* dan *Theory of Planned Behavior* dalam edukasi KB (Rosenstock, 1974; Ajzen, 1991). Pemahaman persepsi risiko dan norma sosial membantu bidan menyusun strategi komunikasi yang efektif.

5. Contoh Implementasi di Lapangan

Pelayanan KB di Puskesmas pedesaan menunjukkan integrasi pelayanan KB dengan pelayanan nifas. Ibu yang datang kontrol nifas diberikan konseling mengenai pilihan kontrasepsi pasca persalinan. Skrining dilakukan menggunakan kriteria kelayakan medis. Klien memilih IUD pasca plasenta setelah mendapatkan informasi lengkap. Edukasi tentang tanda bahaya dan jadwal kontrol diberikan sebelum pulang.

Pendekatan ini memperlihatkan penerapan *continuity of care* dan integrasi pelayanan KIA dengan KB. Monitoring dilakukan melalui kunjungan kader pada minggu kedua untuk memastikan tidak ada keluhan serius. Sistem rujukan disiapkan apabila terjadi komplikasi.

6. Tantangan dan Strategi Penguatan

Pelayanan KB di tingkat primer menghadapi tantangan berupa keterbatasan tenaga terlatih MKJP, distribusi logistik yang tidak merata,

serta resistensi budaya terhadap metode tertentu. Hambatan ini dapat dianalisis melalui teori sistem kesehatan yang menekankan pentingnya penguatan sumber daya, regulasi, dan tata kelola (WHO, 2010).

Strategi penguatan meliputi:

- a. Pelatihan berkala bidan dalam pelayanan MKJP.
- b. Integrasi KB dengan kegiatan Posyandu untuk meningkatkan akses.
- c. Penggunaan sistem reminder berbasis komunitas untuk menekan drop out.
- d. Penguatan jejaring rujukan dengan rumah sakit untuk kasus komplikasi.

Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan teori pelayanan primer, kebijakan nasional, serta praktik berbasis bukti menjadi dasar dalam meningkatkan mutu pelayanan KB di tingkat komunitas. Pelayanan yang terstruktur, terdokumentasi, dan berpusat pada klien akan mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai CPMK-6, CPMK-4, dan CPMK-2.

C. Jejaring dan Kemitraan Pelayanan KB

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) berbasis komunitas tidak dapat dilaksanakan secara efektif tanpa dukungan jejaring dan kemitraan lintas sektor. Teori sistem kesehatan menjelaskan bahwa mutu pelayanan dipengaruhi oleh interaksi berbagai komponen sistem, termasuk penyedia layanan, pembuat kebijakan, komunitas, serta mekanisme rujukan (WHO, 2010). Konsep jejaring dalam pelayanan kesehatan primer menekankan pentingnya koordinasi antar fasilitas untuk menjamin kesinambungan asuhan (Starfield, 1998).

Pelayanan KB di komunitas melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

1. Puskesmas, sebagai koordinator pelayanan kesehatan primer dan pusat rujukan internal wilayah kerja.
2. Praktik Bidan Mandiri, sebagai penyedia layanan langsung di tingkat desa/kelurahan.
3. Rumah Sakit Rujukan (FKRTL), sebagai fasilitas penanganan komplikasi atau tindakan lanjutan.
4. Kader Posyandu, sebagai penggerak dan penghubung antara keluarga dan tenaga kesehatan.
5. PKK dan tokoh masyarakat, sebagai agen advokasi dan penguatan penerimaan sosial terhadap program KB.

Kolaborasi ini selaras dengan teori kolaborasi interprofesional yang menekankan komunikasi efektif, pembagian peran yang jelas, dan tujuan bersama dalam meningkatkan mutu pelayanan (Reeves et al., 2017). Jejaring pelayanan KB memungkinkan distribusi peran yang proporsional sesuai kompetensi masing-masing unsur.

1. Konsep Jejaring dan Rujukan dalam Pelayanan KB

Sistem rujukan dalam pelayanan KB bertujuan menjamin bahwa setiap klien memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan klinisnya. Teori continuity of care menegaskan bahwa rujukan bukan sekadar pemindahan tempat pelayanan, tetapi bagian dari kesinambungan asuhan yang harus disertai komunikasi dua arah dan dokumentasi lengkap (Haggerty et al., 2003).

Alur jejaring rujukan pelayanan KB di tingkat komunitas dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3.2
Alur Jejaring Rujukan Pelayanan KB

Identifikasi risiko dilakukan melalui skrining medis dan penilaian kondisi klien. Stabilitas kondisi memastikan bahwa klien dalam keadaan aman sebelum dirujuk. Rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) dilakukan sesuai indikasi klinis, misalnya komplikasi pemasangan

IUD atau kontraindikasi medis tertentu. Umpan balik dari rumah sakit kepada bidan komunitas menjadi bagian penting dalam kesinambungan pelayanan. Tindak lanjut di komunitas dilakukan untuk memastikan pemantauan pasca tindakan atau pasca komplikasi.

Prinsip sistem rujukan dua arah ini sejalan dengan kebijakan pelayanan kesehatan primer yang menekankan integrasi vertikal dan horizontal antar fasilitas (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

2. Peran Bidan dalam Jejaring Pelayanan KB

Bidan komunitas memegang tanggung jawab sentral dalam membangun dan menjaga jejaring pelayanan KB. Peran tersebut meliputi:

- a. Mengidentifikasi kasus yang memerlukan rujukan berdasarkan standar medis.
- b. Menyiapkan dokumen rujukan yang lengkap dan jelas.
- c. Melakukan komunikasi dengan fasilitas rujukan sebelum pengiriman klien.
- d. Melakukan tindak lanjut pasca rujukan melalui kunjungan rumah atau kontrol ulang.

Teori manajemen pelayanan kesehatan menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi sebagai faktor penentu efektivitas sistem rujukan (Donabedian, 1988). Dokumentasi rujukan yang baik mencerminkan akuntabilitas profesional dan mendukung keselamatan pasien.

Relevansi terhadap CPMK-4 terlihat pada kemampuan mahasiswa merancang dan mengelola jejaring rujukan. Keterkaitan dengan CPMK-6 tampak pada kemampuan melakukan tindak lanjut pasca rujukan. Integrasi CPMK-2 tercermin dalam pendekatan berbasis keluarga yang memastikan keluarga memahami alasan dan proses rujukan.

3. Implementasi Jejaring di Lapangan

Praktik di wilayah pedesaan menunjukkan bahwa kolaborasi antara bidan desa dan Puskesmas mempermudah penanganan kasus efek samping berat kontrasepsi hormonal. Bidan melakukan skrining awal dan stabilisasi, kemudian menghubungi dokter di Puskesmas untuk konsultasi sebelum rujukan. Rumah sakit memberikan laporan balik setelah tindakan. Bidan selanjutnya melakukan kunjungan rumah untuk memastikan kondisi klien stabil.

Pendekatan ini mencerminkan teori kolaborasi lintas sektor yang menekankan koordinasi terstruktur dan pembagian tanggung jawab yang

jas (Reeves et al., 2017). Keberhasilan jejaring sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan sistem pelaporan yang tertib.

4. Tantangan dan Strategi Penguatan Jejaring

Koordinasi yang belum optimal menjadi tantangan utama dalam jejaring pelayanan KB. Hambatan dapat berupa kurangnya komunikasi antar fasilitas, keterlambatan umpan balik rujukan, atau tidak lengkapnya dokumentasi. Faktor budaya dan persepsi masyarakat terhadap rujukan juga dapat memengaruhi keberhasilan sistem.

Pendekatan solusi dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan rutin lintas sektor untuk evaluasi kasus dan perencanaan bersama.
- b. Penggunaan grup komunikasi digital desa untuk mempercepat koordinasi.
- c. Penguatan SOP rujukan dan pelatihan dokumentasi.
- d. Pemberdayaan kader sebagai penghubung informasi antara keluarga dan tenaga kesehatan.

Teori peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) menekankan pentingnya evaluasi berkala dan perbaikan sistem berdasarkan temuan lapangan (Deming, 1986). Jejaring yang kuat tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan KB, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan komunitas secara keseluruhan.

Penguatan jejaring dan kemitraan pelayanan KB merupakan bentuk implementasi manajemen layanan berbasis komunitas yang selaras dengan capaian CPMK-4, didukung kompetensi konseling dan tindak lanjut pada CPMK-6, serta pendekatan keluarga dalam CPMK-2. Integrasi ketiga kompetensi tersebut menjadi fondasi profesionalisme bidan dalam pelayanan KB komunitas yang efektif dan berkelanjutan.

D. Konseling KB Berbasis Hak dan Pengambilan Keputusan Bersama

Konseling Keluarga Berencana (KB) berbasis hak merupakan inti dari pelayanan kesehatan reproduksi yang berpusat pada klien. Pendekatan ini berlandaskan teori hak reproduksi yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi yang lengkap, membuat keputusan secara sukarela, serta mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan bebas diskriminasi (WHO, 2021). Prinsip tersebut sejalan dengan teori etika biomedis yang menekankan otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice dalam praktik pelayanan kesehatan (Beauchamp & Childress, 2019).

Konseling berbasis hak mencakup beberapa prinsip utama. Informasi yang diberikan harus lengkap, akurat, dan seimbang mengenai seluruh pilihan metode kontrasepsi. Proses konseling harus berlangsung tanpa paksaan atau tekanan dari tenaga kesehatan maupun pihak lain. Privasi dan kerahasiaan klien wajib dijaga selama proses komunikasi. Partisipasi pasangan dapat difasilitasi apabila disepakati oleh klien, namun keputusan akhir tetap berada pada individu yang bersangkutan.

Teori *client-centered care* dari Rogers (1961) menekankan pentingnya empati, penerimaan tanpa syarat, dan penghormatan terhadap otonomi klien. Pendekatan ini memperkuat proses pengambilan keputusan bersama (*shared decision making*), yaitu proses kolaboratif antara tenaga kesehatan dan klien dalam menentukan pilihan berdasarkan bukti ilmiah dan preferensi pribadi (Elwyn et al., 2012). Pengambilan keputusan bersama tidak berarti memindahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada klien, melainkan membangun dialog dua arah yang setara dan informatif.

Model konseling yang banyak digunakan dalam pelayanan KB adalah pendekatan GATHER (Greet, Ask, Tell, Help, Explain, Return). Model ini mencerminkan alur komunikasi terapeutik yang sistematis. Tahap Greet menekankan penerimaan dan penciptaan suasana nyaman. Tahap Ask menggali kebutuhan, kekhawatiran, dan riwayat kesehatan klien. Tahap Tell memberikan informasi tentang berbagai pilihan metode secara objektif. Tahap Help membantu klien mempertimbangkan alternatif sesuai kondisi medis dan preferensi. Tahap Explain menjelaskan cara penggunaan, efek samping, dan tanda bahaya. Tahap Return memastikan adanya rencana kunjungan ulang atau tindak lanjut (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Penerapan konseling berbasis hak secara langsung mendukung CPMK-6, yaitu kemampuan melakukan edukasi dan konseling kesehatan reproduksi secara berpusat pada klien. Indikator keberhasilan tidak hanya terletak pada pilihan metode, tetapi juga pada kualitas komunikasi, pemahaman klien terhadap informasi yang diberikan, serta dokumentasi proses pengambilan keputusan.

Contoh praktik dapat dilihat pada seorang ibu nifas yang ragu menggunakan IUD karena mitos infertilitas. Bidan memulai konseling dengan pendekatan empatik dan menggali sumber kekhawatiran ibu. Informasi tentang mekanisme kerja IUD, manfaat, risiko, serta bukti ilmiah terkait fertilitas dijelaskan secara seimbang. Alternatif metode seperti implan dan suntik turut

dipaparkan. Setelah mempertimbangkan kondisi medis dan preferensi pribadi, ibu memilih implan sebagai metode yang dirasakan lebih nyaman. Proses ini menunjukkan penerapan *informed choice dan shared decision making* secara nyata.

Tantangan dalam konseling KB berbasis hak sering muncul dari tekanan keluarga, norma budaya, atau sistem patriarki yang membatasi otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan reproduksi. Teori ekologi sosial menjelaskan bahwa keputusan kesehatan tidak hanya dipengaruhi faktor individu, tetapi juga oleh sistem keluarga dan lingkungan sosial (Bronfenbrenner, 1979). Hambatan ini dapat mengurangi efektivitas konseling jika tidak ditangani secara komprehensif.

Strategi solusi meliputi edukasi pasangan dan tokoh masyarakat, pendekatan komunikasi sensitif budaya, serta penguatan literasi kesehatan reproduksi di tingkat komunitas. Pemberdayaan kader dan pemimpin lokal dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan reproduksi yang rasional dan berbasis informasi. Upaya ini sekaligus memperkuat CPMK-4 melalui penguatan jejaring komunitas dan CPMK-2 melalui pendekatan keluarga dalam proses pengambilan keputusan.

Konseling KB berbasis hak dengan pengambilan keputusan bersama bukan hanya prosedur komunikasi, melainkan praktik profesional yang menuntut kompetensi klinis, etika, dan sosial. Integrasi teori hak reproduksi, komunikasi terapeutik, serta pendekatan keluarga menjadi fondasi dalam mewujudkan pelayanan KB komunitas yang bermutu, adil, dan berkelanjutan.

E. Tindak Lanjut Pengguna KB

Tindak lanjut pengguna Keluarga Berencana (KB) merupakan bagian esensial dari *continuity of care* dalam praktik kebidanan komunitas. Teori *continuity of care* menekankan bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh tindakan awal, tetapi oleh kesinambungan pemantauan, evaluasi, dan respons terhadap kebutuhan klien secara berkelanjutan (Haggerty et al., 2003). Pelayanan KB yang berhenti pada tahap pemberian metode tanpa monitoring berisiko meningkatkan angka putus pakai (*drop out*), ketidakpatuhan, serta komplikasi yang tidak terdeteksi.

Konsep tindak lanjut dalam pelayanan KB juga berkaitan dengan teori mutu pelayanan kesehatan yang dikemukakan oleh Donabedian (1988), yang menilai mutu melalui aspek struktur, proses, dan outcome. Tindak lanjut termasuk dalam dimensi proses dan outcome, karena berhubungan langsung

dengan kepatuhan penggunaan kontrasepsi, kepuasan klien, serta keberlanjutan metode yang dipilih.

1. Bentuk Monitoring dan Tindak Lanjut

Tindak lanjut pengguna KB dilakukan secara sistematis dan terjadwal dengan memperhatikan kondisi medis serta kebutuhan individu. Bentuk monitoring meliputi:

- a. Penetapan jadwal kunjungan ulang, sesuai jenis metode kontrasepsi.
- b. Pemantauan efek samping, baik yang bersifat ringan maupun berat.
- c. Evaluasi kepatuhan penggunaan metode, terutama pada metode jangka pendek seperti pil dan suntik.
- d. Kunjungan rumah apabila klien tidak hadir, sebagai bagian dari pendekatan berbasis komunitas.

Pendekatan ini sejalan dengan teori perilaku kesehatan yang menyatakan bahwa dukungan sosial dan penguatan berkelanjutan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap intervensi kesehatan (Ajzen, 1991). Keterlibatan kader dalam sistem monitoring memperkuat dukungan sosial dan memperkecil risiko drop out.

Relevansi terhadap CPMK-6 terlihat jelas pada kemampuan mahasiswa menyusun rencana tindak lanjut terjadwal dan melakukan monitoring efek samping. Keterkaitan dengan CPMK-2 tampak pada pendekatan keluarga dalam pemantauan, sedangkan CPMK-4 tercermin pada pengelolaan sistem pencatatan dan koordinasi tindak lanjut.

2. Efek Samping KB dan Penanganan di Komunitas

Pemahaman tentang efek samping kontrasepsi menjadi bagian penting dalam tindak lanjut. Edukasi yang tepat dapat mencegah penghentian penggunaan metode akibat kesalahpahaman. Sebagian besar efek samping bersifat ringan dan dapat ditangani di tingkat primer (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Tabel 3.2
Efek Samping KB dan Penanganan di Komunitas

Metode	Efek Samping Umum	Penanganan Awal
Pil	Mual	Dianjurkan konsumsi setelah makan
Suntik	Amenorea	Edukasi bahwa kondisi tersebut umumnya normal
IUD	Nyeri ringan	Analgesik ringan dan observasi
Implan	Perubahan pola haid	Konseling lanjutan dan pemantauan

Sumber: Diadaptasi dari Pedoman Pelayanan Kontrasepsi (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Penanganan awal di komunitas bertujuan memberikan reassurance dan mencegah kecemasan yang tidak perlu. Teori Health Belief Model menjelaskan bahwa persepsi terhadap efek samping dapat memengaruhi keputusan melanjutkan atau menghentikan metode (Rosenstock, 1974). Edukasi yang jelas dan empatik membantu menurunkan persepsi ancaman dan meningkatkan kepatuhan.

Komplikasi serius seperti perdarahan hebat, nyeri berat, atau tanda infeksi memerlukan rujukan segera sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Sistem rujukan dua arah memastikan klien tetap dalam pengawasan setelah kembali ke komunitas.

3. Implementasi Tindak Lanjut di Lapangan

Contoh praktik di lapangan menunjukkan pentingnya koordinasi antara bidan dan kader. Seorang akseptor kontrasepsi suntik tidak datang sesuai jadwal ulang. Kader Posyandu yang melakukan pemantauan rutin melaporkan kepada bidan. Bidan kemudian melakukan kunjungan rumah untuk mengidentifikasi alasan ketidakhadiran, memberikan konseling ulang, serta menyusun jadwal baru.

Pendekatan ini mencerminkan penerapan *continuity of care* dan teori dukungan sosial dalam perubahan perilaku kesehatan. Intervensi berbasis komunitas terbukti meningkatkan kepatuhan dan menurunkan angka putus pakai (BKKBN, 2022).

4. Tantangan dan Strategi Penguatan

Angka *drop out* yang tinggi menjadi tantangan utama dalam program KB. Faktor penyebab meliputi efek samping yang tidak dipahami, kurangnya dukungan pasangan, jarak fasilitas kesehatan, serta lemahnya sistem pencatatan.

Strategi penguatan dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sistem reminder berbasis kader atau pesan singkat digital.
- b. Integrasi pencatatan KB dengan sistem informasi kesehatan desa.
- c. Edukasi berkelanjutan mengenai efek samping normal dan tanda bahaya.
- d. Kunjungan rumah terjadwal untuk kelompok risiko tinggi.

Teori peningkatan mutu berkelanjutan menekankan pentingnya evaluasi rutin dan perbaikan sistem berbasis data (Deming, 1986). Tindak lanjut yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan evaluasi program dan perencanaan intervensi yang lebih efektif.

Tindak lanjut pengguna KB bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan bagian integral dari praktik profesional bidan komunitas. Integrasi monitoring, edukasi, dukungan sosial, dan sistem rujukan memastikan pelayanan KB berjalan berkesinambungan, aman, dan berpusat pada klien. Pendekatan ini mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai CPMK-6 sebagai capaian utama, serta memperkuat aspek manajerial dan pendekatan keluarga dalam CPMK-4 dan CPMK-2.

F. Aktivitas 1 — Knows How Mini-Case

Topik: Pelayanan KB di Tingkat Komunitas: Konseling, Jejaring, dan Tindak Lanjut

Skenario Kasus (Mini-Case)

Seorang perempuan usia 30 tahun, P2A0, datang ke Posyandu bersama kader untuk berkonsultasi mengenai penggunaan kontrasepsi. Ibu memiliki bayi usia 2 bulan dan saat ini menyusui.

Hasil pengkajian awal:

1. Ibu belum menggunakan kontrasepsi pasca persalinan
2. Ibu mengatakan masih ragu memilih KB karena mendengar dari tetangga bahwa KB dapat menyebabkan kemandulan
3. Suami menyerahkan keputusan kepada ibu, tetapi menyarankan metode yang "tidak ribet"
4. Jarak rumah ke Puskesmas ± 7 km
5. Kader menyampaikan bahwa ibu sering tidak datang saat kegiatan Posyandu

Tugas Mahasiswa (Level Knows How)

Mahasiswa diminta untuk menjelaskan dan merencanakan (bukan melakukan tindakan langsung) terkait kasus di atas:

1. Analisis masalah kebidanan dan faktor yang memengaruhi keputusan KB
2. Jelaskan pendekatan konseling berbasis hak (rights-based & client-centered care)
3. Tentukan pilihan metode kontrasepsi yang sesuai dan rasional
4. Jelaskan peran jejaring pelayanan (kader, bidan, Puskesmas)
5. Rancang rencana tindak lanjut (follow-up) berbasis komunitas
6. Identifikasi potensi risiko (drop out, unmet need, efek samping).

G. Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Pelayanan KB Berbasis Komunitas pada Pasangan Usia Subur dengan Unmet Need
3	Kasus	Konseling dan tindak lanjut KB pada ibu dengan unmet need di komunitas
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta mampu menunjukkan kompetensi dalam pelayanan KB berbasis komunitas yang berpusat pada klien, termasuk konseling, jejaring, dan tindak lanjut
5	Kompetensi	1. Anamnesis berbasis komunitas 2. Skrining kelayakan kontrasepsi 3. Perumusan diagnosis/masalah kebidanan komunitas 4. Perencanaan pelayanan KB 5. KIE/konseling berbasis hak 6. Jejaring dan rujukan 7. Tindak lanjut (continuity of care) 8. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 30 tahun, P2A0, tinggal di wilayah kerja Puskesmas, datang saat kegiatan Posyandu. Ibu mengatakan belum menggunakan KB sejak melahirkan 8 bulan yang lalu. Hasil anamnesis: a. Masih menyusui Sebagian b. Takut menggunakan KB karena mendengar efek samping dari tetangga c. Suami belum mendukung penggunaan KB d. Tidak ada riwayat penyakit kronis

		e. Keadaan umum baik, tanda vital normal TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah berbasis komunitas 2. Identifikasi masalah/kebutuhan KB (unmet need) 3. Lakukan skrining kelayakan penggunaan kontrasepsi 4. Tentukan pilihan metode kontrasepsi yang sesuai 5. Berikan KIE/konseling berbasis hak dan shared decision making 6. Jelaskan rencana tindak lanjut (follow up) 7. Jelaskan kemungkinan jejaring/rujukan bila diperlukan
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta sesuai 2. Penilaian berdasarkan checklist (0–3) dan global rating (1–4) 3. Tidak memberikan bantuan 4. Penilaian objektif INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta anamnesis → PS menjawab sesuai scenario 2. Jika skrining → tidak ada kontraindikasi medis 3. Diagnosis yang diharapkan: - PUS dengan unmet need KB 4. Tindakan yang diharapkan: a. Konseling KB berbasis hak b. Menawarkan metode sesuai kondisi c. Melibatkan aspek keluarga/suami 5. Edukasi yang diharapkan: a. Meluruskan mitos efek samping b. Menjelaskan pilihan metode c. Pentingnya KB untuk kesehatan ibu 6. Tindak lanjut: a. Jadwal kunjungan ulang b. Kunjungan rumah/kader c. Rujukan jika diperlukan
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. Berperan sebagai ibu dengan unmet need 2. Tampak ragu dan sedikit cemas 3. Fokus masalah: a. takut efek samping b. suami belum setuju 4. Jika dijelaskan → mulai memahami

		5. Akan bertanya: "Kalau pakai KB, nanti berbahaya tidak, Bu?"
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi, Bu PS: Pagi, Bu Peserta: Apa yang bisa saya bantu? PS: Saya belum pakai KB sejak melahirkan Peserta: Apa alasannya, Bu? PS: Saya takut efek samping, kata tetangga bisa berbahaya Peserta: Apakah suami mendukung? PS: Belum terlalu setuju Peserta: Baik Bu, saya akan membantu menjelaskan pilihan KB yang aman PS: Iya Bu, saya ingin tahu dulu
10	Kebutuhan manikin	Tidak wajib (roleplay konseling komunitas)
11	Kebutuhan laboran	1. Menyiapkan ruang OSCE 2. Menyiapkan lembar penilaian 3. Mengatur alur peserta
12	Kebutuhan alat	1. Meja dan kursi 2. Lembar status pasien 3. Lembar penilaian 4. Alat tulis 5. Leaflet KB 6. Buku KIA (opsional)
13	Penulis	(Isi sesuai penulis)
14	Referensi	1. World Health Organization. (2021). <i>Family planning/contraception</i>. WHO. https://www.who.int 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). <i>Pedoman pelayanan kontrasepsi</i>. Kemenkes RI. 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). <i>Pedoman pelayanan KB</i>. BKKBN. 4. Saifuddin, A. B. (2020). <i>Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi</i>. Yayasan Bina Pustaka. 5. Rogers, C. (1961). <i>On becoming a person</i>. Houghton Mifflin. 6. Elwyn, G., et al. (2012). Shared decision making. <i>Journal of General Internal Medicine</i>, 27(10), 1361–1367. 7. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). <i>Principles of biomedical ethics</i>. Oxford University Press. 8. Haggerty, J. L., et al. (2003). Continuity of care. <i>BMJ</i>, 327(7425), 1219–1221. 9. Bronfenbrenner, U. (1979). <i>The ecology of human development</i>. Harvard University Press.

		10.Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). <i>Health program planning</i> . McGraw-Hill.
--	--	---

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Pelayanan KB Berbasis Komunitas

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif (Anamnesis Berbasis Komunitas)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama / unmet need KB		
2. Status reproduksi / menyusui		
3. Riwayat penggunaan kontrasepsi sebelumnya		
4. Riwayat obstetri (GPA, persalinan terakhir)		
5. Riwayat penyakit kronis / obat-obatan		
6. Faktor sosial / keluarga (dukungan pasangan, budaya, norma)		
7. Preferensi dan kekhawatiran klien		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Melakukan semua 7 langkah dengan benar
- 2= Melakukan 4–6 langkah dengan benar
- 1= Melakukan 1–3 langkah dengan benar
- 0= Tidak melakukan

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis dan Perencanaan Layanan KB

1. Persiapan

Komponen	Skoring	Skor
a. Menyapa klien dengan sopan		
b. Memperkenalkan diri		
c. Menjelaskan tujuan konseling KB		
d. Meminta persetujuan		
e. Menjaga privasi		
f. Hand hygiene		
g. Menyiapkan alat / lembar konseling		

2. Langkah-langkah

Komponen	Skoring	Skor
a. Menilai kondisi umum klien		
b. Mengidentifikasi unmet need		
c. Melakukan skrining kelayakan KB		
d. Mengidentifikasi kontraindikasi medis		
e. Menentukan pilihan metode KB sesuai kebutuhan		
f. Memberikan KIE / konseling berbasis hak		

g. Melibatkan anggota keluarga sesuai kebutuhan		
h. Menyesuaikan metode dengan preferensi klien		
i. Menjelaskan cara penggunaan dan efek samping		
j. Menjelaskan tanda bahaya / red flags		
k. Menyusun rencana tindak lanjut / follow-up		

3. Pasca Tindakan

Komponen	Skoring	Skor
a. Menyimpulkan hasil konseling		
b. Melakukan dokumentasi		
c. Merapikan alat / ruang		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Melakukan 15–20 langkah dengan tepat & sistematis
- 2= Melakukan 10–14 langkah cukup tepat
- 1= Melakukan 1–9 langkah
- 0= Tidak melakukan / tidak tepat

KOMPETENSI 3. KIE / Konseling Berbasis Hak

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan kondisi dan kebutuhan klien		
3. Menjelaskan pilihan metode KB		
4. Menjelaskan efek samping & mitos		
5. Memberi kesempatan bertanya		
6. Menjawab dengan jelas dan empatik		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Semua 6 langkah benar
- 2= 4–5 langkah benar
- 1= 1–3 langkah benar
- 0= Tidak melakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sistematis		
2. Menjaga privasi		
3. Empati terhadap klien		
4. Komunikasi jelas & tenang		
5. Percaya diri		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= 5 langkah benar
- 2= 4 langkah benar
- 1= 1–3 langkah benar
- 0= Tidak melakukan

$$\text{TOTAL SKOR} = (K1 + K2 + K3 + K4) / 3$$

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100 =$$

(Kota),.....

.....

Penguji :

H. Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Topik: Pelayanan KB Berbasis Komunitas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus KB Komunitas
Metode penilaian	DOPS adalah metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan mahasiswa dalam praktik komunitas. Penilai mengamati tindakan nyata mahasiswa, kemudian memberi umpan balik segera. Domain yang dinilai: komunikasi, informed consent, persiapan, keterampilan teknis, keselamatan pasien, profesionalisme.	Pembimbing mengamati mahasiswa saat melakukan konseling KB di Posyandu, skrining kelayakan KB, membantu klien memilih metode sesuai hak reproduksi, serta menyiapkan tindak lanjut dan rujukan jika diperlukan.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa memberikan pelayanan KB berbasis komunitas yang aman, efektif, dan berpusat pada klien, mempertimbangkan kondisi medis, sosial, dan preferensi keluarga.	Mahasiswa dinilai dari kemampuan melakukan konseling, menjelaskan pilihan metode, mempertimbangkan preferensi klien, dan menyusun tindak lanjut berbasis komunitas.
Kasus klinik	Kasus diambil dari situasi nyata atau simulasi berbasis komunitas, memungkinkan mahasiswa menunjukkan keterampilan klinik dan manajerial.	Seorang ibu P2A1, berusia 30 tahun, hadir di Posyandu dengan kebutuhan KB. Ibu ingin menunda kehamilan berikutnya, khawatir efek samping MKJP, dan ingin konsultasi bersama pasangan.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Observasi dilakukan saat mahasiswa menjalankan tindakan nyata: pengkajian, konseling, skrining, pemilihan metode, edukasi, dan tindak lanjut.	Mahasiswa menyapa ibu, melakukan anamnesis riwayat reproduksi dan sosial, menilai unmet need, memberikan edukasi berbasis hak, menyusun rencana kunjungan ulang, dan mendokumentasikan keputusan klien.
Aspek yang dinilai	Kemampuan melakukan anamnesis, ketepatan skrining, pemilihan metode, KIE, keselamatan pasien, profesionalisme, dan kemampuan menghargai keputusan klien (informed choice).	Pembimbing menilai apakah mahasiswa menghubungkan kondisi sosial, keluarga, dan medis dengan pilihan KB, serta memberikan edukasi yang jelas dan empatik.

Fokus observasi pembimbing	Observasi performa nyata mahasiswa, termasuk sistematis, aman, efektif, serta pengambilan keputusan klinis.	Pembimbing mengamati apakah mahasiswa melakukan konseling berbasis hak, melibatkan pasangan bila perlu, memilih metode tepat, menjelaskan risiko/efek samping, dan menjaga privasi serta kepercayaan klien.
Umpan balik	Diberikan segera setelah observasi, mencakup kelebihan dan area perbaikan, spesifik dan konstruktif.	Pembimbing memberi komentar bahwa mahasiswa baik dalam komunikasi dan keterlibatan keluarga, tetapi perlu lebih teliti dalam skrining kontraindikasi dan menyusun jadwal tindak lanjut.
Keputusan penilaian	Dikategorikan: kompeten, perlu supervisi, atau remedial, berdasarkan ketepatan tindakan, keselamatan, komunikasi, dan pengambilan keputusan.	Mahasiswa kompeten jika mampu melakukan konseling, memilih metode sesuai hak klien, menyusun tindak lanjut, dan dokumentasi dengan benar. Perlu supervisi jika masih memerlukan arahan. Remedial jika salah memilih metode atau tidak melakukan skrining dengan benar.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mencapai level "does" pada taksonomi Miller. Menilai performa nyata di lapangan.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori KB komunitas, tetapi mampu menerapkan pelayanan, melakukan konseling, mengambil keputusan klinis, dan mengelola tindak lanjut secara berkelanjutan.

I. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 3.3
Portofolio pada Pelayanan KB Berbasis Komunitas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pelayanan KB Berbasis Komunitas
Hakikat portofolio	Kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.	Memuat bukti mahasiswa mampu melakukan asesmen kebutuhan KB di komunitas, memberikan konseling, mendampingi penggunaan metode kontrasepsi, dan melakukan monitoring kepatuhan serta edukasi berkelanjutan.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik lapangan.	Mahasiswa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memilih metode KB sesuai kondisi sosial dan budaya komunitas, serta mengatasi kekhawatiran warga setelah mendapatkan feedback dari CI/dosen.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan performa nyata di lapangan.	OSCE memuat hasil ujian konseling KB berbasis simulasi komunitas, DOPS memuat observasi langsung saat mahasiswa melakukan pelayanan KB di masyarakat, termasuk skrining, edukasi, dan follow-up klien.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus klien yang ditangani mahasiswa, mencakup	Mahasiswa menuliskan kasus pasangan usia subur di desa X

	data penting, masalah, tindakan, dan hasil.	yang membutuhkan KB, mencatat preferensi, masalah sosial, dan metode KB yang dipilih, serta tindak lanjut monitoring.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien dan mencegah kesalahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya konseling yang jelas agar penggunaan kontrasepsi aman, memperhatikan kontraindikasi, dan memastikan kesadaran klien tentang efek samping.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari CI/dosen sebagai bukti pembinaan, menunjukkan kekuatan dan area perlu ditingkatkan.	CI menilai mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan pasangan dan keluarga, tetapi perlu meningkatkan kemampuan mengatasi resistensi budaya atau mitos terkait KB.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi bukti yang dikembangkan berulang dan berkesinambungan dengan fokus pada konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa interaksi pelayanan KB di komunitas, bukan hanya satu kasus, sehingga terlihat konsistensi kemampuan konseling dan monitoring.
Bukti konsistensi kompetensi	Memperlihatkan kemampuan mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan feedback terlihat mahasiswa konsisten mampu memberikan pelayanan KB berbasis komunitas secara efektif dan aman.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran terlihat dalam performa nyata yang berulang dan berkembang.	Mahasiswa menunjukkan penerapan teori pelayanan KB berbasis komunitas secara konsisten, adaptif terhadap konteks lokal, dan aman.

Tabel 3.4
Case Report pada Pelayanan KB Berbasis Komunitas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pelayanan KB Berbasis Komunitas
Hakikat case report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus klien yang ditangani mahasiswa di komunitas.	Mahasiswa menyusun laporan tentang pasangan usia subur di desa X yang membutuhkan KB, termasuk pertimbangan sosial, ekonomi, dan preferensi klien.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengintegrasikan data, analisis masalah, tindakan, dan evaluasi.	Mahasiswa menjelaskan alasan pemilihan metode KB tertentu, strategi edukasi komunitas, dan rencana tindak lanjut monitoring.
Isi laporan	Identitas klien, data subjektif dan objektif, analisis, diagnosis, tindakan, evaluasi.	Data: pasangan usia subur, ingin menunda kehamilan, memiliki kekhawatiran terkait efek KB → analisis → metode KB progestin dipilih → edukasi → tindak lanjut monitoring.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, analisis, dan keputusan klinis.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa memilih metode KB yang sesuai konteks komunitas dan logis secara klinis.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi.	Mahasiswa belajar bahwa pelayanan KB harus berbasis bukti, konteks sosial, dan komunikasi efektif dengan klien.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori ke praktik nyata.	Mahasiswa mampu menerapkan teori pelayanan KB komunitas secara sistematis dan adaptif.

Tabel 3.5
Refleksi Patient Safety pada Pelayanan KB Berbasis Komunitas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pelayanan KB Berbasis Komunitas
Hakikat refleksi	Tulisan yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko dan mencegah kesalahan klinis atau sosial.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memastikan pilihan KB aman bagi klien, mengantisipasi efek samping, dan menyesuaikan edukasi dengan budaya lokal.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran keselamatan pasien/klien dalam praktik kebidanan berbasis komunitas.	Mahasiswa memahami bahwa salah konseling atau pemilihan KB dapat menimbulkan risiko kesehatan dan sosial bagi klien.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.	Risiko: pemahaman klien rendah, efek samping, resistensi budaya. Pencegahan: komunikasi jelas, edukasi berulang, monitoring pasca pemberian KB.
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang membahayakan klien atau komunitas.	Efek samping KB tidak diketahui, salah pilih metode, mitos/kepercayaan yang menghalangi kepatuhan.
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko.	Edukasi berulang, skrining medis, konseling keluarga, pemantauan penggunaan KB.
Pembelajaran mahasiswa	Apa yang dipelajari dan perbaikan ke depan.	Mahasiswa belajar pentingnya komunikasi efektif, adaptasi budaya, dan konsistensi monitoring KB di komunitas.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis.	Mahasiswa mampu meningkatkan kualitas pelayanan KB berbasis komunitas secara aman dan berkelanjutan.

J. Rangkuman Materi

Bab ini membahas secara komprehensif pelayanan Keluarga Berencana (KB) di tingkat komunitas dengan pendekatan kebidanan berbasis keluarga, pelayanan primer, continuity of care, dan rights-based approach. Rangkuman berikut menyajikan poin-poin inti yang merepresentasikan keseluruhan materi:

1. Konsep KB Berbasis Komunitas

Keluarga Berencana merupakan upaya pengaturan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Pelayanan KB berbasis komunitas dilaksanakan dengan prinsip berpusat pada klien, berbasis keluarga, berkelanjutan sepanjang siklus kehidupan, serta menghormati hak reproduksi. Pendekatan ini menempatkan bidan sebagai fasilitator pengambilan keputusan yang sadar dan sukarela.

2. Pelayanan KB di Tingkat Primer

Pelayanan KB di Puskesmas, Posyandu, dan praktik mandiri bidan mengikuti alur sistematis: pengkajian, konseling, pemilihan metode, pelayanan tindakan, edukasi, tindak lanjut, dan rujukan bila diperlukan. Pelayanan primer menekankan aksesibilitas, kesinambungan, komprehensivitas, dan koordinasi layanan. Mutu pelayanan tidak hanya ditentukan oleh cakupan, tetapi juga oleh kualitas proses dan hasil pelayanan.

3. Jejaring dan Kemitraan Pelayanan KB

Pelayanan KB komunitas memerlukan kolaborasi antara Puskesmas, praktik bidan mandiri, rumah sakit rujukan, kader Posyandu, PKK, dan tokoh masyarakat. Sistem rujukan dua arah menjadi bagian penting dari continuity of care. Bidan bertanggung jawab memastikan komunikasi efektif, dokumentasi rujukan yang lengkap, serta tindak lanjut pasca rujukan.

4. Konseling KB Berbasis Hak dan Pengambilan Keputusan Bersama

Konseling KB harus menjamin informasi yang lengkap dan seimbang, bebas dari paksaan, menjaga privasi, serta menghormati otonomi klien. Pendekatan GATHER membantu bidan melakukan konseling secara sistematis. Pengambilan keputusan bersama (shared decision making) memastikan metode kontrasepsi dipilih berdasarkan kondisi medis, kebutuhan, dan preferensi klien.

5. Tindak Lanjut Pengguna KB

Tindak lanjut merupakan bagian integral dari pelayanan berkelanjutan. Monitoring dilakukan melalui jadwal kunjungan ulang, pemantauan efek

samping, evaluasi kepatuhan, dan kunjungan rumah bila klien tidak hadir. Penanganan efek samping ringan dapat dilakukan di komunitas, sedangkan komplikasi serius memerlukan rujukan sesuai SOP. Sistem reminder berbasis kader dan pencatatan terintegrasi menjadi strategi penting untuk menekan angka drop out.

6. Relevansi terhadap Capaian Pembelajaran

Materi dalam bab ini mendukung pencapaian CPMK-6 melalui penguatan kompetensi konseling dan tindak lanjut berbasis hak. Aspek pengelolaan layanan dan jejaring rujukan memperkuat CPMK-4. Pendekatan berbasis keluarga dan kesinambungan layanan memperkuat CPMK-2. Integrasi ketiga kompetensi tersebut membentuk landasan profesionalisme bidan komunitas dalam pelayanan KB.

Secara keseluruhan, pelayanan KB di tingkat komunitas bukan sekadar pemberian kontrasepsi, melainkan proses asuhan kebidanan yang komprehensif, berkelanjutan, terintegrasi dalam sistem pelayanan primer, serta berlandaskan prinsip etika dan hak reproduksi. Pemahaman menyeluruh terhadap konsep, kebijakan, praktik, dan tindak lanjut menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan KB yang bermutu, aman, dan berpusat pada klien.

Tabel 3.5
Red Flags & Eskalasi Pelayanan KB Berbasis Komunitas

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perdarahan pervaginam banyak atau berkepanjangan setelah penggunaan kontrasepsi	Kemungkinan efek samping berat atau gangguan hormonal yang memerlukan evaluasi lebih lanjut	Lapor ke pembimbing/dokter, evaluasi kondisi umum klien, pertimbangkan penghentian metode dan rujukan
Tidak haid disertai tanda kehamilan (mual, payudara tegang)	Kemungkinan kegagalan kontrasepsi dan kehamilan	Lakukan tes kehamilan, hentikan kontrasepsi sementara, rujuk untuk evaluasi
Nyeri hebat pada perut bawah	Dapat mengarah pada kehamilan ektopik atau komplikasi lain	Segera evaluasi, lakukan rujukan emergensi
Tanda infeksi pada alat kontrasepsi (misal implan, IUD) di rumah klien (kemerahan, nyeri, bengkak, keluar cairan)	Infeksi lokal akibat prosedur	Lapor ke petugas kesehatan, lakukan perawatan luka sesuai SOP, pertimbangkan rujukan jika berat
Sakit kepala berat atau gangguan penglihatan	Kemungkinan efek samping serius atau kondisi neurologis	Hentikan sementara penggunaan kontrasepsi, evaluasi medis segera
Peningkatan berat badan yang signifikan dan cepat	Efek samping hormonal atau faktor lain yang perlu dikaji	Edukasi pola hidup, evaluasi penyebab, pertimbangkan ganti metode KB sesuai kebutuhan
Klien tidak patuh penggunaan (lupa minum pil, terlambat suntik)	Risiko kegagalan kontrasepsi meningkat	Edukasi ulang, pilih metode yang lebih sesuai (misal implan atau suntik), lakukan konseling tambahan
Klien ingin menghentikan kontrasepsi karena efek samping atau mitos	Risiko drop out KB	Konseling ulang, tawarkan alternatif metode, lakukan informed choice dan follow-up
Ditemukan kontraindikasi baru selama penggunaan KB	Risiko keselamatan klien	Hentikan metode, lakukan evaluasi medis, rujuk ke fasilitas kesehatan jika diperlukan
Reaksi alergi atau hipersensitivitas setelah vaksin atau suntikan KB (misal ruam, sesak nafas ringan)	Efek samping serius yang memerlukan perhatian	Hentikan prosedur, berikan pertolongan awal, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat

K. Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab : Pelayanan KB Berbasis Komunitas
Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Tanggal : _____
Tempat Praktik/Lapangan Komunitas : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan pelayanan KB berbasis komunitas	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan asesmen kebutuhan KB di komunitas (usia subur, kependudukan, preferensi)	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan identifikasi pasangan usia subur yang memerlukan KB	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menanyakan riwayat penggunaan kontrasepsi sebelumnya di komunitas	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menanyakan riwayat menstruasi, kehamilan, dan keluhan terkait KB	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menanyakan riwayat penyakit kronis atau obat yang sedang digunakan	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menanyakan preferensi dan kekhawatiran klien terkait KB	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa melakukan skrining kelayakan metode KB hormonal dan non-hormonal	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa mengidentifikasi kontraindikasi penggunaan metode KB tertentu	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menentukan metode KB yang sesuai dengan kondisi dan preferensi klien	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa memberikan edukasi mengenai cara kerja, penggunaan, kelebihan dan kekurangan metode KB	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan efek samping yang mungkin terjadi dan langkah pencegahannya	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya/red flags yang memerlukan evaluasi atau rujukan	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menyesuaikan metode KB dan edukasi sesuai konteks sosial, budaya, dan preferensi klien	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menyusun rencana tindak lanjut dan monitoring penggunaan KB di komunitas	☐	☐	_____

16	Saya sudah bisa mendokumentasikan jenis KB, edukasi, dan rencana tindak lanjut secara ringkas dan jelas	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama pelayanan KB di komunitas	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

L. Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
[https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). *Laporan kinerja Program Bangsa Bangsa Kencana tahun 2022*. BKKBN.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. MIT Press.
- Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? *Journal of the American Medical Association*, 260(12), 1743–1748.
<https://doi.org/10.1001/jama.260.12.1743>
- Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., ... Barry, M. (2012). Shared decision making: A model for clinical practice. *Journal of General Internal Medicine*, 27(10), 1361–1367.
<https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6>
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2003). *Family nursing: Research, theory, and practice* (5th ed.). Prentice Hall.
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health program planning: An educational and ecological approach* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Haggerty, J. L., Reid, R. J., Freeman, G. K., Starfield, B. H., Adair, C. E., & McKendry, R. (2003). Continuity of care: A multidisciplinary review. *BMJ*, 327(7425), 1219–1221.

<https://doi.org/10.1136/bmj.327.7425.1219>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kementerian Kesehatan RI.
- Marmi. (2021). Asuhan kebidanan komunitas. Pustaka Pelajar.
- Rogers, C. R. (1961). On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy. Houghton Mifflin.
- Rosenstock, I. M. (1974). Historical origins of the health belief model. *Health Education Monographs*, 2(4), 328–335.
<https://doi.org/10.1177/109019817400200403>
- Saifuddin, A. B. (2020). Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Starfield, B. (1998). Primary care: Balancing health needs, services, and technology. Oxford University Press.
- World Health Organization. (2010). Monitoring the building blocks of health systems: A handbook of indicators and their measurement strategies. WHO Press.
- World Health Organization. (2021). Family planning: A global handbook for providers (3rd ed.). WHO Press.

PROFIL PENULIS



Dian Rahmawati, SST, MPH., Lahir di Kediri, 31 Oktober 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik pada Program Studi D4 Bidan Pendidik, Poltekes Kemenkes Malang tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri. Saat ini penulis bekerja di Universitas Strada Indonesia mengampu mata kuliah Asuhan Kehamilan dan Asuhan Neonatus, Bayi, dan Balita. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dianrahmawati3110@gmail.com



Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes., merupakan dosen tetap dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kader Bangsa Palembang. Penulis adalah bidan profesional yang memiliki kepakaran di bidang kesehatan reproduksi dan pelayanan kebidanan komunitas. Lahir di Palembang pada 1 Agustus 1988, Penulis menyelesaikan pendidikan DIV Kebidanan pada tahun 2010, meraih gelar Magister Kesehatan pada tahun 2015, dan menuntaskan program profesi bidan pada tahun 2023. Dalam aktivitas akademiknya, Penullis mengampu mata kuliah Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi, Asuhan Kebidanan Komunitas, serta Asuhan Kebidanan Perempuan dan Anak dalam Kondisi Rentan. Fokus risetnya mencakup upaya preventif dan promotif kesehatan ibu dan anak, dengan penekanan pada kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kontrasepsi. Kontak korespondensi dapat dilakukan melalui email: ramdhanilist@gmail.com.

Sinopsis

Buku ajar "Pelayanan Kebidanan Komunitas: Gizi Ibu, Bayi, dan Balita, Kesehatan Reproduksi Remaja, serta Keluarga Berencana di Tingkat Komunitas" disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan untuk memahami konsep, prinsip, serta implementasi pelayanan kebidanan yang berorientasi pada komunitas. Buku ini menekankan pentingnya pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta pelayanan yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, dan keluarga.

Materi diawali dengan pembahasan mengenai gizi ibu, bayi, dan balita di komunitas, yang menguraikan berbagai permasalahan gizi prioritas, seperti anemia, kekurangan energi kronis (KEK), dan stunting. Pada bagian ini dibahas faktor penyebab, dampak terhadap kesehatan ibu dan anak, metode skrining di tingkat komunitas, strategi pencegahan, edukasi gizi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, serta peran bidan dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sepanjang siklus kehidupan.

Selanjutnya, buku membahas kesehatan reproduksi remaja di komunitas sebagai upaya membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Materi mencakup konsep dasar kesehatan reproduksi remaja, perubahan fisik dan psikososial pada masa remaja, edukasi mengenai perilaku hidup sehat, pencegahan perilaku berisiko, kesehatan menstruasi, pencegahan penyakit menular seksual, pencegahan kehamilan pada usia remaja, serta mekanisme deteksi dini dan rujukan apabila ditemukan permasalahan kesehatan reproduksi. Pembahasan juga menyoroti pentingnya komunikasi efektif, konseling, dan keterlibatan keluarga, sekolah, serta masyarakat dalam mendukung kesehatan reproduksi remaja.

Bagian berikutnya mengupas pelayanan keluarga berencana di tingkat komunitas sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. Topik ini membahas konsep keluarga berencana, berbagai metode kontrasepsi, pelayanan konseling, mekanisme jejaring pelayanan, sistem rujukan, tindak lanjut akseptor, serta peran bidan dalam meningkatkan akses dan keberlangsungan pelayanan keluarga berencana melalui pendekatan berbasis komunitas.

Seluruh materi dalam buku ini disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teori, kebijakan nasional, standar pelayanan, dan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*). Penyajian materi diarahkan untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*), sehingga tidak hanya meningkatkan penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan

klinis, komunikasi, kolaborasi interprofesional, dan pemecahan masalah kesehatan di masyarakat.

Buku ajar ini diharapkan menjadi referensi yang komprehensif bagi mahasiswa, dosen, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memahami dan mengimplementasikan pelayanan kebidanan komunitas secara profesional. Dengan penguasaan materi yang disajikan, pembaca diharapkan mampu memberikan pelayanan yang bermutu, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam percepatan penurunan anemia, KEK, stunting, peningkatan kesehatan reproduksi remaja, dan optimalisasi program keluarga berencana sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional.

Buku ajar "Pelayanan Kebidanan Komunitas: Gizi Ibu, Bayi, dan Balita, Kesehatan Reproduksi Remaja, serta Keluarga Berencana di Tingkat Komunitas" disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan untuk memahami konsep, prinsip, serta implementasi pelayanan kebidanan yang berorientasi pada komunitas. Buku ini menekankan pentingnya pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta pelayanan yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, dan keluarga.

Materi diawali dengan pembahasan mengenai gizi ibu, bayi, dan balita di komunitas, yang menguraikan berbagai permasalahan gizi prioritas, seperti anemia, kekurangan energi kronis (KEK), dan stunting. Pada bagian ini dibahas faktor penyebab, dampak terhadap kesehatan ibu dan anak, metode skrining di tingkat komunitas, strategi pencegahan, edukasi gizi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, serta peran bidan dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sepanjang siklus kehidupan.

Selanjutnya, buku membahas kesehatan reproduksi remaja di komunitas sebagai upaya membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Materi mencakup konsep dasar kesehatan reproduksi remaja, perubahan fisik dan psikososial pada masa remaja, edukasi mengenai perilaku hidup sehat, pencegahan perilaku berisiko, kesehatan menstruasi, pencegahan penyakit menular seksual, pencegahan kehamilan pada usia remaja, serta mekanisme deteksi dini dan rujukan apabila ditemukan permasalahan kesehatan reproduksi. Pembahasan juga menyoroti pentingnya komunikasi efektif, konseling, dan keterlibatan keluarga, sekolah, serta masyarakat dalam mendukung kesehatan reproduksi remaja.

Bagian berikutnya mengupas pelayanan keluarga berencana di tingkat komunitas sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. Topik ini membahas konsep keluarga berencana, berbagai metode kontrasepsi, pelayanan konseling, mekanisme jejaring pelayanan, sistem rujukan, tindak lanjut akseptor, serta peran bidan dalam meningkatkan akses dan keberlangsungan pelayanan keluarga berencana melalui pendekatan berbasis komunitas.

Seluruh materi dalam buku ini disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teori, kebijakan nasional, standar pelayanan, dan praktik berbasis bukti (evidence-based practice). Penyajian materi diarahkan untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student-centered learning), sehingga tidak hanya meningkatkan penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, komunikasi, kolaborasi interprofesional, dan pemecahan masalah kesehatan di masyarakat.

Buku ajar ini diharapkan menjadi referensi yang komprehensif bagi mahasiswa, dosen, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memahami dan mengimplementasikan pelayanan kebidanan komunitas secara profesional. Dengan penguasaan materi yang disajikan, pembaca diharapkan mampu memberikan pelayanan yang bermutu, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam percepatan penurunan anemia, KEK, stunting, peningkatan kesehatan reproduksi remaja, dan optimalisasi program keluarga berencana sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-82-4 (PDF)



9

786347

756824